Formato para crear Tesinas

1. Estructura de la Portada

La primera página debe contener los siguientes elementos en este orden:

- **Nombre de la Institución:** Institución principal y facultad (Ej. *Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Odontología*).
- **Título del trabajo:** Centrado y en mayúsculas (Ej. *ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO...*).
- **Tipo de trabajo y propósito:** Se debe especificar qué es y para qué se presenta (Ej. *TESINA QUE PARA OBTENER EL TITULO DE [Tu carrera]*).
- **Autor:** Con la leyenda "PRESENTA:" seguida de tu nombre completo.
- **Asesores:** Nombre del Director y del Asesor del trabajo.
- **Lugar y fecha:** Ciudad y año de presentación (Ej. *México, D.F. 1998*).

2. Páginas Preliminares

- **Restricciones de Uso / Derechos de Autor:** Una página dedicada a especificar que el documento es para fines educativos e informativos, prohibiendo la reproducción total o parcial con fines de lucro y citando la Ley Federal del Derecho de Autor.
- **Agradecimientos:** Página(s) dedicada(s) a agradecer a las personas e instituciones que apoyaron el trabajo (Ej. A Dios, a los padres, a los hermanos, amigos y profesores/asesores).

3. Índice General

El índice debe estructurarse con el siguiente orden y niveles jerárquicos:

- Prólogo
- Introducción
- Antecedentes
- **Capítulos (Numeración decimal):**
    - Los capítulos principales llevan un solo número (Ej. *Capítulo 1*).
    - Los subtemas utilizan numeración decimal (Ej. *1.1, 1.2*).
    - Los sub-subtemas agregan otro decimal (Ej. *1.1.1, 1.1.2*).
    - Si se requieren listas dentro de los subtemas, se utilizan letras minúsculas con paréntesis de cierre (Ej. *a), b), c)*).
- Conclusiones
- Propuesta
- Bibliografía

4. Estructura del Cuerpo del Trabajo

- **Prólogo:** Explica el motivo de desarrollar la tesina, los objetivos que persigue y la necesidad a la que responde.

- **Introducción:** Profundiza en el tema, define conceptos clave y establece los propósitos del estudio.
- **Antecedentes:** Resumen histórico y evolución del tema de estudio, mencionando autores clave y fechas (orden cronológico).
- **Desarrollo (Capítulos):** Desarrollo exhaustivo de la investigación.
- **Conclusiones:** Resultados finales derivados de la investigación.
- **Propuesta:** Sugerencias, planes o tratamientos derivados de las conclusiones.
- **Bibliografía:** Lista final de referencias.

APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL ÁREA DE LA SALUD

1. COPILOT. Asistente de escritura y análisis para redacción y programación científica.
2. CHATGPT. Modelo de lenguaje versátil para generar ideas, resúmenes y explicaciones complejas.
3. CHATPDF. Interacción directa con artículos científicos en PDF para extraer y comprender información clave.
4. CONSENSUS. Buscador de evidencia científica para encontrar respuestas validadas por estudios.
5. GEMINI. IA multimodal de Google para razonamiento avanzado, análisis de datos y búsqueda.
6. PERPLEXITY. Motor de búsqueda conversacional con citas precisas para investigación actualizada.
7. DEEPL. Traductor de alta precisión para documentos médicos y literatura en múltiples idiomas.
8. CONNECTEDPAPERS: Visualiza redes de citación para descubrir artículos relacionados.
9. ELICIT: Asistente de investigación que automatiza la revisión de literatura.
10. SCISPACE: Plataforma para entender artículos científicos con IA, chatear con PDFs y generar explicaciones.
11. SEMANTICSCHOLAR: Buscador académico inteligente que utiliza IA para entender el contexto de la búsqueda.

APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

1. CHATGPT: Modelo de lenguaje conversacional versátil para múltiples tareas.
2. DEEPSEEK: Potente en codificación, matemáticas y razonamiento avanzado.
3. GEMINI: IA multimodal de Google integrada en su ecosistema.
4. PERPLEXITY: Motor de búsqueda conversacional con citas y fuentes.
5. COPILOT: Asistente de IA integrado en Microsoft 365 para productividad.
6. CLAUDE: IA enfocada en seguridad, ética y procesamiento de documentos largos.
7. GROK: IA con acceso a información en tiempo real de X, conocida por su tono.

HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA INVESTIGACIÓN

1. CONSENSUS: Busca y sintetiza respuestas científicas de papers.

2. DEEPL: Traductor preciso para documentos y textos académicos.

3. RESEARCHRABBIT: Descubre y mapea investigaciones relacionadas visualmente.

4. NOTEBOOKLM: Asistente de IA para organizar y entender tus fuentes.

5. JASPER: Generador de texto para acelerar la redacción académica.

6. SCITE AI: Analiza y verifica cómo se citan los artículos científicos.

7. CONNECTED PAPERS: Visualiza la red de papers y sus conexiones bibliográficas.

CARTEL DE INVESTIGACIÓN AMIC

- Los interesados deberán llenar la siguiente información:
    - Nombre completo del autor
    - Correo electrónico
    - Teléfono
    - Nombre de los coautores (incluido el asesor)
    - Institución a la que pertenece y donde se realizó el trabajo
- Solo puede participar en máximo 2 carteles como primer autor
- Podrá participar en otros resúmenes como coautor
- El autor principal deberá tener el consentimiento de todos los coautores que se registren en el resumen presentado
- Los autores no pueden dividir un estudio en varias presentaciones
- El contenido del resumen, deberá ser producto de una investigación original
- Los títulos múltiples (títulos en serie o numéricos) serán rechazados
- Seleccionar en la casilla el área de conocimiento en la que se desea participar y debe ser acorde al tema de investigación
- **El Resumen**, (máximo 300 palabras) debe contener la siguiente información:
    - Título (no mayor a 12 palabras y de preferencia escrito con letras mayúsculas)
    - Objetivo
    - Introducción o antecedentes
    - Metodología
    - Resultados
    - Conclusiones
- **Si desea presentar casos clínicos**, el resumen deberá contener:
    - Título
    - Introducción o antecedentes
    - Objetivo
    - Presentación del caso con diagnóstico y tratamiento
    - Resultados del tratamiento y/o conclusiones

Registro de participantes

- Los carteles serán presentados únicamente por los estudiantes y no deberá presentar más de 2 carteles como autor
- Para que los resúmenes sean registrados, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la página del congreso
- Las memorias se publicarán un mes después del evento
- La colocación de carteles será el **9 de mayo**
- Colocación: 08:00 - 10:00 h
- Exposición: 10:00 - 13:00 h
- Retiro del cartel: 13:00 h

Para cualquier información relacionada con el evento, consultar la página www.odonto.unam.mx o dirigirse al siguiente correo: amicunam@fo.odonto.unam.mx

FORMATO DEL CARTEL DE AMIC

- El cartel deberá medir 90 cm. de ancho por 1.20 m de alto
- El título deberá colocarse en la parte superior y al centro del cartel. Las letras del título deberán ser de 2.5cm de altura aproximadamente
- Debajo del título, colocar el nombre de la institución que representa y donde se realizó el trabajo
- Inmediatamente después, colocar los nombres del autor principal y presentador con un asterisco y los nombres de los colaboradores
- Las letras del texto y las de los pies de figuras y tablas deberán ser de 1 cm de altura para que puedan ser leídas a 2 metros de distancia
- El cartel deberá versar exclusivamente sobre el contenido del resumen
- La secuencia del cartel deberá estar indicada para facilitarle al espectador su lectura
- El costo por montaje y uso de mamparas es de $400.00 por cartel, este costo deberá cubrirse del 6 al **8 de mayo** en el área de registro del congreso, frente a los salones Olmecas del World Trade Center, CDMX.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO

1.Registro Aquí puedes registrarte y crear una cuenta para poder ingresar las veces que necesites y modificar tu resumen, hasta la fecha límite.

2. Ingreso del resumen Puedes ingresar y modificar datos personales, tu resumen o imprimir tu comprobante. Recuerda que tu resumen debe constar máximo de 300 palabras (divididas en los campos que ahí se presentan).

3. Comprobante Aquí podrás imprimir el comprobante de registro de tu resumen. Es importante que llenes todos los campos ya que así lo entregarás el día del congreso.

Tu información será enviada a nuestra base de datos y ya no podrás hacer cambios.

4. Imprime tu comprobante Imprime tu comprobante, el cual contiene tu número de registro y luego da click en el botón terminar.

5.- Termina tu registro

Orden Cronológico para realizar un cartel científico para investigación

Paso 1: Revisar los lineamientos del congreso. Antes de diseñar, debes conocer las exigencias del evento. La dimensión estándar suele ser el formato A0 (118.9 x 84.1 cm) Verifica si la orientación exigida es vertical (retrato) u horizontal (apaisado). Ignorar esto resultará en un cartel recortado o mal ajustado en los paneles del evento

Paso 2: Sintetizar la información y estructurarla. Aplica la regla del 50/50: 50% de información textual y 50% de elementos visuales (gráficas, figuras, tablas) Utiliza la regla del 6x6, procurando que tus párrafos no excedan las 6 líneas y cada sección tenga un máximo de 250 palabras

La **estructura obligatoria** debe contener:

Título: Corto y llamativo (no más de 4-5 palabras centrales si es posible).

Autores y Adscripción: Tu nombre, afiliación (logos institucionales) y correo. Deben ir en un tamaño menor al título .

Introducción: Pregunta de investigación y objetivos.

Metodología: Especialmente importante para justificar la recolección de tus datos de salud.

Resultados: Es el corazón del cartel. Debe ser altamente visual.

Conclusiones: Qué aporta la investigación a la práctica clínica o científica.

Referencias y Agradecimientos: Breves e impresos en un tamaño pequeño.

Paso 3: Elección de herramientas, diseño y colorimetría Selecciona la herramienta digital, define tu paleta de colores y elige la tipografía (detalles más abajo). Apóyate en plantillas prediseñadas para ahorrar horas de alineación y estructuración.

Paso 4: Inserción de gráficos e imágenes (Consideraciones Éticas en Salud). Es vital el rigor en esta etapa. En el área médica, debes tener el consentimiento informado por escrito de los pacientes para utilizar fotografías clínicas, especialmente si muestran el rostro o patologías específicas. Asegúrate de que todas las imágenes o gráficos tengan una resolución de al menos 300 ppi (puntos por pulgada) para evitar que se pixelen al imprimir. Evita fotos distorsionadas o de repositorios con marcas de agua. Si presentas datos no publicados, puedes agregar un ícono indicando que está prohibido que los asistentes tomen fotografías.

Paso 5: Exportación, revisión exhaustiva e impresión Exporta el documento siempre en formato PDF estándar para impresión. Revisa el archivo final haciendo zoom para detectar errores tipográficos o textos solapados.

Tips de Diseño, Tipografía y Colorimetría

Tipografía y Tamaños: No sobrecargues el póster usando letras minúsculas. Los tamaños recomendados para una lectura cómoda a 1-1.5 metros de distancia son:

Título principal: 32 puntos o más

Subtítulos (secciones): 24 a 28 puntos

Texto general (cuerpo): 18 a 20 puntos

Referencias/Notas al pie: 12 a 14 puntos Para la lectura en bloques de texto, algunas convenciones de diseño sugieren fuentes Serif (con patines, como Times New Roman) para facilitar la lectura , mientras que para los títulos, fuentes Sans-serif (sin patines, como Arial) aportan limpieza y visibilidad Evita usar más de dos fuentes distintas para mantener la uniformidad

Colorimetría: Apunta a la "pregnancia" (impacto visual claro y recordable) . Elige tres tonos basándote en el círculo cromático . Puedes generar alto contraste combinando opuestos (ej. azules/turquesas con naranjas) y utilizar un tercer color neutro (como un gris claro o tono crema) para mediar y equilibrar la composición. No satures de colores estridentes, o harás que la lectura sea molesta

Logos: Trata los logos de las universidades o clínicas con cuidado; no los deformes y asegúrate de que estén en alta calidad, pues de lo contrario demeritan el aspecto profesional

Herramientas y Librerías Recomendadas

BioRender: Es la mejor herramienta absoluta para el área de la salud/biomédica. Contiene iconos científicos pre-vectorizados de altísima calidad (órganos, ADN, equipos médicos, virus) . Además, incluye plantillas exactas para pósters científicos con los espacios ya distribuidos para títulos, logos y gráficos

Canva / PictoChart: Alternativas muy accesibles y gratuitas que ofrecen plantillas (templates) para posters y elementos gráficos fáciles de modificar

PowerPoint: Sumamente confiable si ajustas el tamaño de la diapositiva en centímetros (ej. 118.9 x 84.1 cm) desde el inicio . Es compatible con todo, aunque requiere más habilidad para alinear los cuadros de texto.

DaFont: Un banco de tipografías gratuitas útil si quieres destacar el título principal con letras más modernas

Trucos y Atajos (Ahorro de Tiempo y Mejora de Calidad)

Gráficos con anotaciones centrales: No exportes una gráfica estadística de Excel o SPSS y la pegues sin más. Añádele recuadros o flechas anotadas destacando la conclusión o hallazgo principal en esa misma imagen. Así el lector comprenderá tus resultados en segundos sin tener que leer toda la metodología

Cuidado con el papel de impresión (El Secreto de la Estética): No uses papel Bond de bajo gramaje, ya que la tinta humedece el papel, provocando que se arrugue y se vea muy descuidado al colgarlo Por otro lado, un papel fotográfico extremadamente brillante (como propalcote grueso) puede reflejar las luces del salón y dificultar la lectura Solicita un papel de gramaje intermedio (150 a 170 gramos) con acabado mate

Mini Guía de Citación Vancouver

1. En el Texto (La Cita)

No uses nombres ni fechas, solo números. Estos números deben seguir el orden en que aparecen por primera vez.

- Una sola fuente: "El lavado de manos reduce el riesgo de infección (1)."
- Varias fuentes: "Diversos estudios confirman esta teoría (1, 3, 5-8)."
- Autor mencionado: "Según García (2), el tratamiento es efectivo."

En la Bibliografía (La Referencia)

La lista al final del documento se numera según el orden de aparición.

Artículo

- Formato: Autor. Título. Revista. Año;Vol(Nº):Págs.
- Ejemplo: Pérez A. Cirugía robótica. Rev Med. 2024;12(2):45-50.

Libro

- Formato: Autor. Título. Edición. Ciudad: Editorial; Año.
- Ejemplo: Gómez L. Anatomía Humana. 3ª ed. Madrid: Ed. Médica; 2023.

Sitio Web

- Formato: Autor/Org. Título [Internet]. Año [citado fecha]. URL
- Ejemplo: OMS. Guía COVID-19 [Internet]. 2025 [citado 10 mar 2026]. Disponible en: http://oms.int/guia

Opciones en línea para realizarlas

- Zotero
- Mendeley
- MyBib

Requisitos de presentación de cartel para el congreso nacional e internacional de posgrado de investigación de odontología 2026

- En esta modalidad se aceptarán casos clínicos y/o investigaciones y/o revisiones de literatura
- El contenido del cartel debe corresponder al contenido del resumen aceptado.
- El cartel deberá medir 90 cm de ancho por 120 cm de alto.
- Deberá usar la plantilla proporcionada a continuación para la elaboración de su cartel.
- Presentación Cartel Power Point
- En el cartel se debe colocar el escudo de su universidad y/o facultad o escuela correspondiente, con un tamaño sugerido de 10×10 cm.
- Colocar el nombre de la institución que representa, al centro del cartel.
- El título del trabajo deberá colocarse por debajo de la institución.
- Las letras del título deberán ser de 90 puntos de altura aproximadamente.
- Colocar los nombres del autor principal (*con asterisco) y los nombres de los coautores.
- Debajo de los nombres de los autores deben estar las adscripciones de cada autor y ser indicados con superíndices.
- Las letras del texto deben ser aproximadamente de 45 puntos y la de los pies de figura o tablas deben ser de 30 puntos (tamaño sugerido).
- La secuencia del cartel deberá estar indicada para facilitar su lectura.
- Todos los carteles serán evaluados por un comité revisor.
- La constancia de participación académica se enviará electrónicamente.

LISTA DE VERIFICACIÓN CARE PARA ARTÍCULOS DE CASO CLÍNICO.

Título : El diagnóstico o la intervención del foco principal seguido de las palabras “informe de caso”.

Palabras clave: de 2 a 5 palabras clave que identifiquen diagnósticos o intervenciones en este informe de caso (incluido "informe de caso").

Resumen – (estructurado o no estructurado)

- Introducción: ¿Qué tiene de singular este caso y qué aporta a la literatura científica?
- Las principales preocupaciones del paciente y los hallazgos clínicos importantes.
- Los diagnósticos principales, las intervenciones y los resultados.
- Conclusión: ¿Cuáles son una o más lecciones que se pueden extraer de este informe de caso?

Introducción : resume brevemente por qué este caso es único y puede incluir referencias a la literatura médica.

- Información para el paciente
- Información anonimizada específica del paciente.
- Principales preocupaciones y síntomas del paciente.
- Antecedentes médicos, familiares y psicosociales, incluyendo información genética relevante.
- Intervenciones previas relevantes y sus resultados.

Hallazgos clínicos : Describa los hallazgos significativos del examen físico (EF) y los hallazgos clínicos importantes.

Cronología : Información histórica y actual de este episodio de atención organizada en forma de cronología (figura o tabla).

Evaluación diagnóstica

- Métodos de diagnóstico (exploración física, pruebas de laboratorio, imágenes, encuestas).
- Retos diagnósticos.
- Diagnóstico (incluidos otros diagnósticos considerados).
- Características pronósticas, cuando corresponda.

Intervención terapéutica

- Tipos de intervención terapéutica (farmacológica, quirúrgica, preventiva).
- Administración de la intervención terapéutica (dosis, potencia, duración).
- Cambios en las intervenciones terapéuticas con sus explicaciones.

Seguimiento y resultados

- Resultados evaluados por el médico y el paciente, si están disponibles.
- Resultados importantes de pruebas diagnósticas de seguimiento y otras pruebas.
- Adherencia y tolerabilidad a la intervención. (¿Cómo se evaluó esto?)
- Eventos adversos e imprevistos.

Discusión

- Fortalezas y limitaciones de su enfoque en este caso.
- Análisis de la literatura médica pertinente.
- La justificación de sus conclusiones.
- Las principales conclusiones extraídas de este informe de caso (sin referencias) se resumen en un párrafo.

Perspectiva del paciente: El paciente debe compartir su perspectiva sobre el/los tratamiento(s) que recibió.

Consentimiento informado: El paciente debe dar su consentimiento informado. (Proporcionarlo si se solicita).

2

VIGENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS BIOMÉDICOS Y PRECLÍNICOS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA ODONTOLÓGICA EN ALUMNOS DE ODONTOLOGÍA.

GUILLERMO ARTURO CEJUDO LUGO
guillermocej@hotmail.com
JOSÉ CANO BROWN, ALBERTO JIMÉNEZ ÁVILA , VICTOR AZUARA PAVON, EDUARDO STEIN GEMORA, ÁLVARO EDGAR GONZÁLEZ ARAGON
UNAM
FES-IZTACALA

INTRODUCCIÓN: Los conocimientos biomédicos y preclínicos adquiridos a lo largo de los primeros años de la carrera de Cirujano Dentista, son de vital importancia para el desarrollo de las futuras habilidades durante la práctica odontológica, ya que otorgan al alumno el aprendizaje asociativo, pensamiento crítico y científico que le darán sustento de una buena práctica profesional. La integración de los contenidos curriculares fomentará las capacidades y habilidades teóricas que los llevarán a brindar la mejor atención a sus pacientes.

OBJETIVOS: Identificar la vigencia de los conocimientos biomédicos y preclínicos en la práctica clínica de los alumnos de cuarto año de la Carrera de Cirujano Dentista de la FES Iztacala.

MATERIAL / MÉTODOS: Se realizó un estudio no experimental y transversal que recolecta datos en un sólo momento y tiempo único. Es descriptivo y correlacional ya que describen el comportamiento de los alumnos con relación a la vigencia de sus conocimientos biomédicos y preclínicos en la práctica clínica en las clínicas odontológicas, con un enfoque cuantitativo, pues es secuencial y probatorio, se aplicó Estadística descriptiva. Población de estudio Alumno(a)s de cuarto año de la Carrera de Cirujano Dentista de la FES Iztacala, del Ciclo Escolar 2020-0. El tipo de muestreo fue aleatorio estratificado. Criterios de Inclusión: Alumnos de cuarto año de la carrera de Cirujano Dentista de la FES Iztacala, del Ciclo Escolar 2020-0. Criterios de Exclusión: Alumnos de cualquier otro grado escolar y no pertenecientes a la FES Iztacala. Criterios de Eliminación: Alumnos que no completaron o no aceptaron contestar el cuestionario. Instrumento de Medición El instrumento de medición se construyó a través de los siguientes pasos: A. Diseño del Instrumento 1. Análisis y definición de las variables 2. Revisión de contenidos que nos servirían de guía para la elaboración de los ítems 3. Separación de los ítems por asignatura, y variables 4. Digitalización de los Ítems en la plataforma. Para su registro, el cuestionario se constituyó de 50 ítems.

RESULTADOS: La cantidad total de alumnos encuestados fue de 298. Distribuyéndose de la siguiente manera: 66 alumnos (22.14%) de Clínica Aragón, 62 estudiantes (20.8%) Clínica Acatlán, 48 alumnos (16.1%) de la Clínica Iztacala, 46 estudiantes (15.43%) de Clínica Cuautepec, 31 alumnos (10.40%) de la Clínica Cuautitlán, 30 estudiantes (10.06%) de la Clínica Molinito y 15 alumnos (5.03%) de Clínica Almaraz. La distribución respecto

al género, fue la siguiente: En la clínica de Acatlán participaron 31 hombres (10.40%) y 31 mujeres (10.40%), mientras que en la Clínica Almaraz del género masculino fueron 3 (1.00%) y del género femenino 12 (4.02%). En tanto que en la Clínica Aragón: 37 hombres (12.41%) y 29 mujeres (9.73%). De la Clínica Cuautepec, 20 hombres (6.71%) y 26 mujeres (8.72%). En la Clínica Cuautitlán 12 participantes hombres (4.02%) y 19 participantes mujeres (6.37%). En la Clínica Iztacala 10 (3.35%) fueron masculinos y 38 (12.75%) fueron femeninos. Y en la Clínica Molinito fueron 6 (2.01%) del género masculino y 24 (8.05%) del género femenino. El promedio escolar entre 8 y 8.49 fue el de mayor frecuencia con 90 alumnos, enseguida se observó el segmento de 7.50 y 7.99 con 63 estudiantes. Mientras que los de menor frecuencia fue el de 9.5 y 10 con 5 alumnos, seguido del intervalo de 6 y 6.49 con 13 alumnos. Vigencia de la Dimensión Académica de los Conocimientos Biomédicos en la Práctica Clínica Odontológica por Clínicas Odontológicas. El promedio general de la Vigencia de los Conocimientos Biomédicos en todas las clínicas odontológicas estudiadas fue de 3.34. La clínica con mejor promedio de vigencia fue la de Almaraz con 3.86, seguida de Aragón con 3.58, después Acatlán con 3.37, posteriormente Iztacala con 3.25. Mientras que las de menor de vigencia fueron la clínica Cuautepec con 3.19, Cuautitlán con 3.13 y finalmente la clínica Molinito con 3.05. Vigencia de la Dimensión Académica de los Conocimientos Preclínicos en la Práctica Clínica Odontológica por Clínicas Odontológicas. La vigencia de los conocimientos preclínicos en general de las clínicas odontológicas fue de 3.88. La clínica con mejor rango es Acatlán con 4.13, seguida de Cuautitlán con 3.95, posteriormente se encuentran Aragón y Molinito con 3.91, y las clínicas con menor rango de vigencia son Iztacala con 3.89, Cuautepec con 3.79 y por último Almaraz con 3.61.

CONCLUSIONES: Se llevó a cabo una encuesta aplicada a 298 alumnos de la FES Iztacala de la carrera de Cirujano Dentista por medio de un Cuestionario tipo Likert que consta de 55 ítems, 5 generales y 50 específicos, basados en cuatro Subdimensiones Preclínicas y ocho Subdimensiones Biomédicas de la carrera de Cirujano Dentista de la FES Iztacala. Se generó un instrumento de medición confiable y con un resultado en alfa de Crombach de 0.9761602733. Los resultados de las encuestas se midieron en una escala de 0 a 5, siendo 1 una deficiente vigencia y 5 una excelente vigencia.

3

FRECUENCIA DE FLUOROSIS EN ALUMNOS DE PRIMER INGRESO DE LA CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA DE LA FES-ZARAGOZA UNAM

MARIA DEL PILAR ADRIANO ANAYA
adriano124@hotmail.com
TOMAS CAUDILLO JOYA, PILAR ALEJANDRA CAUDILLO ADRIANO, MIRELLA FEINGOLD STEINER.
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN: Se presentan los resultados realizados sobre fluorosis de los estudiantes de primer ingreso a la carrera de Cirujano Dentista de la FES-Zaragoza del período 2019.

OBJETIVOS: Identificar la frecuencia de fluorosis por su zona de procedencia de los alumnos de primer ingreso período 2017, de la carrera de Cirujano dentista de la FES-Zaragoza UNAM.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudios de tipo descriptivo, observacional y transversal. Muestra conformada por 315 estudiantes de primer ingreso que firmaron su consentimiento informado para participar en este estudio. La información fue capturada en el programa SSS versión 23.0.

RESULTADOS: 281 estudiantes no presentaron ningún tipo de fluorosis, 21 de ellos muy leve, 11 leve, y sólo 2 moderada.

CONCLUSIONES: Con respecto a la zona de procedencia, la edad y el sexo de los alumnos y la fluorosis, no se encontraron diferencias significativas, comportándose este problema de manera similar.

4

PREVENCIÓN INTEGRAL COMO PRÁCTICA SOCIAL EN UN MODELO ESTOMATOLÓGICO DE PRÁCTICA PROFESIONAL INTEGRAL

TOMAS CAUDILLO JOYA
caudillo_adriano@hotmai.com
MARIA DEL PILAR ADRIAO ANAYA, PILAR ALEJANDRA CAUDILLO ADRIANO, MIRELLA FEINGOLD STEINER
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES-ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN: Se presentan los resultados que se han obtenido en los escolares que se encuentran en el Internado Infantil Guadalupano, después de tres años de estar trabajando en un Modelo Estomatológico de Práctica profesional Integral con el propósito detener una población libre de caries dental.

OBJETIVOS: Describir las acciones de prevención integral odontológicas realizadas en un Modelo Estomatológico de Práctica profesional Integral dentro del Internado Infantil Guadalupano.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio longitudinal, donde participan todos los escolares del Internado. La información se capturó en el programa de cómputo SPSS versión 23.0 donde se obtienen estadísticas descriptivas como son promedios, DS, Porcentajes.

RESULTADOS: programa de promoción, cada tres meses los alumnos de segundo año de la carrera de la FES-Zaragoza UNAM, dieron pláticas educativas de salud bucal, dentro de los salones de clase. Programa protección específica. Se realizó técnica de cepillado, aplicación de selladores de fosetas y fisuras en molares y premolares permanentes sanos, control de placa dentobacteriana y profilaxis cada seis meses a todos los escolares. programa curativo, se identificaron las necesidades de tratamiento bucal, eliminando focos infecciosos, se resolvieron lesiones en tejidos blandos benignas, no se realizaron acciones de rehabilitación a través de aparatología fija y/o removible.

CONCLUSIONES: Se ha reducido a 1.2 dientes cariados y aumentar a 2.4 dientes obturados de estos escolares.

5

CARIES DENTAL EN HIJOS CON MADRES QUE TIENEN LA PROFESIÓN DE CIRUJANAS DENTISTAS

MARIA DEL PILAR ADRIANO ANAYA
adriano124@hotmail.com
TOMAS CAUDILLO JOYA, PILAR ALEJANDRA CAUDILLO ADRIANO, MIRELLA FEINGOLD STEINER
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES-ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN: Se presentan los resultados de la prevalencia de caries dental de alumnos de primer ingreso a la carrera de Cirujano Dentista de la FES-Zaragoza cuyas madres han estudiado la carrera de Cirujanas Dentistas.

OBJETIVOS: Identificar la prevalencia de caries dental de alumnos de la carrera de Cirujano Dentista de la FES-Zaragoza, cuyas madres son Cirujanas Dentistas.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio descriptivo, transversal y observacional. La información se obtuvo de la base de datos de la Línea de Investigación Salud Pública en Estomatología con número de registro LI-FESZ-341110 de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. El estudio se conformó con los alumnos de primer ingreso de los períodos 2017, 2018, 2019 y 2020, que tienen madres con profesión en odontología. La información se capturó en el Programa SPSS versión 23.0.

RESULTADOS: En este estudio participaron 47 alumnos con madres que tienen la profesión de cirujano dentista Los promedios de dientes con historia de caries dental de estos alumnos es de 7.7 dientes con historia de caries dental, de los cuales 5.1 dientes en promedio se encuentran cariados, no se encontraron dientes extraídos por caries dental y 2.3 dientes en promedio se encontraron obturado.

CONCLUSIONES: En este estudio no se comprobó la tesis que sustenta que los hijos de los odontólogos tienen menos caries dental, que el resto de la población.

6

PERCEPCIÓN QUE TIENE UN GRUPO DE ESCOLARES SOBRE UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIFICA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL

TOMAS CAUDILLO JOYA
caudillo_adriano@hotmai.com
MARIA DEL PILAR ADRIAO ANAYA, PILAR ALEJANDRA CAUDILLO ADRIANO, MIRELLA FEINGOLD STEINER
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES-ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS: Identificar la percepción de los escolares de la Alcaldía Milpa Alta, de la protección específica y promoción de salud bucal.

MATERIAL / MÉTODOS: El estudio fue de tipo transversal, descriptivo y observacional. La muestra estuvo conformada por 705 que se encontraron en las primarias al momento de la aplicación de la encuesta estos escolares pertenecían al grupo intervención que participó durante seis años dentro de un programa de protección específica y promoción de la salud bucal con el propósito de disminuir la caries dental en un 50%.

RESULTADOS: Con respecto al conocimiento que deben tener los escolares sobre la estructura de su boca el 86% de ellos lo tiene. Con respecto al cepillado de su boca. El 56% contestó que siempre lava sus dientes, el 43% algunas veces y el 1% nunca. Después de haber participado en el Programa de Salud Bucal consideras a los dentistas que te atendieron como: El 5% de los escolares contestó que los considera como enemigos a y el 95% respondió que como amigos. Te gustaría seguir participando en un Programa de Salud Bucal cuando termines la Primaria. El 5% contestó que no y el 95% que si

CONCLUSIONES: Con respecto a las respuestas y con base a los resultados de los dos programas los objetivos del proyecto fueron cubiertos con acciones de bajo costo y de amplia cobertura.

7

ESTILOS DE VIDA Y SALUD BUCAL EN ESCOLARES DE 12 AÑOS

LUIS MORENO HERNÁNDEZ
luis.moreno@correo.buap.mx
ZARATE FLORES ALMA DELIA, CORTEZ RODRIGUEZ BLANCA, CORDERO PEREA HAZEL, MACHUCA MENDOZA DAYRA CECILIA
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA

INTRODUCCIÓN: Las condiciones sociales en las que se vive y trabaja se han convertido en una latente preocupación por la influencia en la salud bucal dejando secuelas que podrían ser prevenibles sobre todo en los escolares por lo que se debe trabajar con el impacto que generan

OBJETIVOS: Identificar la relación entre estilos de vida y salud bucal en escolares de 12 años

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal observacional durante el periodo primavera 2022 a 34 escolares. Se recolecto el índice de CPO, índice de O´Leary y la aplicación de la encuesta ¿Cómo es mi estilo de vida? con 10 dominios y 45 ítems enviado mediante encuesta electrónica. <30 los estilos de vida ponen en riesgo la salud; 31-48 tiene estilos de vida protectores, pero otros ponen en riesgo; 49-59 el estilo es adecuado, pero debe mejorar; 60-70 tiene estilos de vida saludables

RESULTADOS: Edad promedio de 12 años de los cuales el 55.9 son mujeres y el 44.1 son hombres, el porcentaje de placa dentobacteriana es de 53.08%, respecto al índice de CPO, el índice general es de 4.7 siendo un índice alto, respecto al cuestionario de estilos de vida el 71% presentan estilos de vida con factores protectores y solo el 4 % tiene estilos de vida adecuados, respecto al peso solo el 47% cuenta con un peso adecuado

CONCLUSIONES: Es necesario implementar programas de prevención para la salud bucal, así como controlar la formación de placa y caries. Mejor los estilos de vida de los escolares

8

MODULO CLÍNICA EN PREVENCIÓN HIGIENE BUCAL, PACIENTES, EN LA CLÍNICA ZARAGOZA FES UNAM

LISANDRO J HERNANDEZ CHAVEZ
lizandrohernandez485@gmail.com
BEATRIZ GURROLA MARTÍNEZ, LIZETH PALOMA REVUELTA BUSTAMANTE, MA. SOCORRO ÁLVAREZ MARTINEZ, JAQUELINE A FUENTES BADILLO
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN: La bioplaca (Bp) es un factor causante de enfermedades, consideradas un problema de salud bucal en México como la caries dental y la enfermedad periodontal. La higiene bucal sigue siendo la medida de prevención más utilizada para reducir el avance de la enfermedad periodontal

OBJETIVOS: identificar presencia de bioplaca por pacientes con profilaxis en el Módulo Clínica en prevención en la clínica Zaragoza.

MATERIAL / MÉTODOS: Metodología estudio, descriptivo, transversal. Muestra n= 1172 pacientes de 16 a los 80 años de edad, atendidos en el Módulo Clínica en Prevención en la clínica Zaragoza por los alumnos de primer año para la aplicación de profilaxis. Procedimiento en los grupos 3101 y 3103 se aplicó la medida preventiva para la enfermedad periodontal. Se inicio con el levantamiento del índice epidemiológico IHOS, registrándose 3 veces. Se obtuvo el promedio, y porcentajes.

RESULTADOS: Se muestra que el 96.15% de la población estudiada desconocía la presencia de la bioplaca. Respecto a los promedios registrados: se observó una disminución en los pacientes ya que en el primer el porcentaje de pacientes con bioplaca fue de 37.79%, en el segundo de 15.59% y el final de 9.53% .

CONCLUSIONES: Las profilaxis realizadas por los estudiantes, son de gran importancia para la población aledaña de la FES Zaragoza ya que trata de resolver los problemas de salud bucal

9

ERUPCIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES PACIENTES DEL MÓDULO CLÍNICA EN PREVENCIÓN CLÍNICA ZARAGOZA. 2019

JAQUELINE ANDREA FUENTES BADILLO
jackeeline999@gmail.com
BEATRIZ GURROLA MARTÍNEZ, SOCORRO ÁLVAREZ MARTINEZ. MA JULIA RIVERA NAVARRO, LISANDRO J HERNÁNDEZ CHÁVEZ.
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN: El momento ideal para la exodoncia del 3er molar es cuando ha alcanzado los dos tercios de su desarrollo, coincide generalmente entre los 16 y18 años, aunque algunos de estos molares están impactados o sin erupcionar, ocasionalmente, llegan hacerlo de manera normal y otros causan problemas clínicamente.

OBJETIVOS: Determinar etapas de erupción de terceros molares en Clínica en Prevención con registro de Seino, como diagnóstico de extracción profiláctica.

MATERIAL / MÉTODOS: Metodología: estudio descriptivo transversal, muestra por conveniencia 29 pacientes en edades de 8 a 16 años, procedimiento: los pacientes de los grupos 3101 y 3103 Modulo Clínica en Prevención. Se informo y solicito a los padres que participaran sus niños, traer la radiografía panorámica. Sobre el negatoscopio se sobre impuso la plantilla de Seino la cual se tomó como referencia en la valoración de las etapas (7) de erupción de los terceros molares.

RESULTADOS: Coincidiendo con lo reportado por Seino se observó que el germen dentario del 3er molar se encuentra presente en pacientes desde los 8,12,15 años. Entre los 9 y 13 el 27 % en las etapas de formación y la terminación de la corona. Formación de las criptas de los terceros, las calcificaciones de la corona y de la mandíbula de 9.9 10.9 y 10.8 años. Terminó de la formación de la corona en el maxilar y la mandíbula: en las edades promedio de 13.3 y 13.2 años formación de la raíz.

CONCLUSIONES: Se realizan extracciones de terceros molares por alumnos de 4º año sin considerar protocolo profiláctico, hacerlas en las primeras etapas de formación es menos traumático.

11

PREVALENCIA DE HALITOSIS EN PACIENTES QUE ACUDEN A LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UAEMEX.

MIGUEL ANGEL PADILLA MILLAN
padillamillan@hotmail.com
MARILUZ DÍAZ GUZMÁN, JESÚS ÁNGEL CARMONA HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER JASSO RODRÍGUEZ , MARILUZ PADILLA DÍAZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN: La Halitosis, es un padecimiento común en el ser humano, causado por los compuestos volátiles sulfurosos emanados de la cavidad bucal e interior del cuerpo. Es alteración con etiología multifactorial.

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia Y etiología de Halitosis en pacientes que acuden a la Facultad de Odontología en el periodo 2020.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio observacional, descriptivo, transversal, muestra de 100 pacientes; seleccionados de manera aleatorio simple. El diagnóstico de Halitosis se realizó por medio de una valoración organoléptica. Donde un examinador se colocó a 10cm de la cavidad bucal de cada paciente; calificando el grado de halitosis según la escala de Rosenberg, donde 0 es ausencia y 5 es halitosis grave. En base a una historia clínica médico-dental y cuestionario que evaluó hábitos higiénicos y dietéticos.

RESULTADOS: Resultados La prevalencia de Halitosis en pacientes que acuden a la Facultad de Odontología es del 82%. El 94% de los casos de Halitosis tienen origen en cavidad bucal. La Halitosis Patológica extrabucal, con un porcentaje mínimo de 6%. No están bajo tratamiento médico 5% de los pacientes que refieren tener alguna afección sistémica Mayor prevalencia de halitosis en el rango de edades de 46-55 años con 24%. En el 6% de los pacientes hay presencia de halitosis, aun teniendo buena higiene.

CONCLUSIONES: La prevalencia de Halitosis en pacientes alcanzó 82%. El 94% de los casos de Halitosis tienen origen en cavidad bucal. La edad es un factor que incrementa conforme avanza.

12

IMPACTO DE LA SALUD BUCAL EN LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD: UN ESTUDIO TRANSVERSAL

ALVARO GARCIA PEREZ
alvaro.garcia@unam.mx
TERESA VILLANUEVA GUTIÉRREZ, JACQUELINE ADELINA RODRÍGUEZ CHÁVEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

INTRODUCCIÓN: La calidad de vida relacionada con la salud es un concepto multidimensional que incluye componentes físicos, emocionales y sociales y su relación con la salud bucal es poco investigada.

OBJETIVOS: Determinar el impacto de la salud bucal en la calidad de vida relacionada con la salud en adultos mayores en la CDMX.

MATERIAL / MÉTODOS: Se incluyó 140 sujetos entre junio-diciembre 2021. Se les aplicó el cuestionario SF-36, compuesto de 36 ítems y ocho dimensiones. El puntaje se calculó y luego se convirtió en dos puntajes totales: puntajes resumidos del componente físico (PCS) y del componente mental (MCS). Fue utilizado el GOHAI que incluye 12 preguntas relacionadas con la salud bucal. En ambos cuestionarios a mayor puntuación mejor calidad de vida relacionada con la salud.

RESULTADOS: 71.4% fueron mujeres, 57.8% tiene ≥12 dientes perdidos, 73.5% usa prótesis bucal, 58.6% presenta caries y 70.7% de los adultos mayores considera su salud bucal como mala. En el modelo de regresión múltiple, la percepción subjetiva del estado de salud bucal demostró un mayor impacto negativo en la calidad de vida relacionada con la salud en ambos componentes [MCS (β=-5.91; $p<0.001$) y PCS (β=-3.96; $p<0.001$)] respectivamente, después de controlar por las variables edad, sexo, uso de prótesis bucal y dientes perdidos.

CONCLUSIONES: La percepción subjetiva de los adultos mayores sobre su estado de salud bucal tuvo un mayor impacto negativo en su calidad de vida relacionada con la salud.

13

PREVALENCIA DE CARIES USANDO EL ÍNDICE ICDAS II EN ESCOLARES DE 8-12 AÑOS

ALVARO GARCIA PEREZ
alvaro.garcia@unam.mx
TERESA VILLANUEVA GUTIÉRREZ
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

INTRODUCCIÓN: Las lesiones incipientes son consecuencia del proceso desmineralización-re-mineralización de las estructuras dentarias que clínicamente presentan una superficie porosa sin cavitación. Además, pueden aparecer áreas de re-mineralización o pueden progresar a cavitación en un periodo de tiempo variable.

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia de caries en dentición mixta en escolares de 8-12 años de Naucalpan estado de México.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio transversal realizado en dos escuelas primarias del municipio de Naucalpan (n=728). Para el diagnóstico de caries en la dentición mixta se efectuó a través del ICDAS II (International Caries Detection and Assessment System) las categorías fueron: Sano (ICDAS=0), lesiones incipientes (ICDAS=1-2), lesiones moderadas (ICDAS=3-4) y lesiones extensas (ICDAS=5-6), para la higiene bucal fue utilizado el IHO-S. Un examinador estandarizado realizó las mediciones y se obtuvo un nivel de Kappa=0.89.

RESULTADOS: 50.9% niños y 49.1% niñas. 48.8% presentaron mala higiene, 45.9% no ha visitado al dentista en los últimos 6 meses y solo el 40.4% se cepilla los dientes ≥2 veces al día. Con respecto a la prevalencia de caries (primaria+permanente), el porcentaje fue de ICDAS=1-2 (11.4%), (ICDAS=3-4) (51.2%) e ICDAS=5-6) fue de 18.8%. No se asoció la gravedad de caries al sexo (p=0.926). por otra parte, la mala higiene bucal se asoció a la presencia de caries extensa (p=0.002). No se encontraron dientes permanentes extraídos por caries.

CONCLUSIONES: Se encontró un elevado porcentaje de lesiones moderadas se necesitan estrategias de prevención con el objetivo de disminuir este tipo de lesiones y que no avancen a lesiones extensas.

14

PRESENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES CON MENOPAUSIA

MARIA ELENA GONZALEZ ARREAGA
mareunam@hotmail.com
CÉSAR FABIÁN LÓPEZ LÓPEZ, GABRIEL MARTÍNEZ CARRILLO, KAREN TREJO MARTÍNEZ, SANDRA FARANGO ANGELES
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

INTRODUCCIÓN: La menopausia es una etapa determinante en la vida de las mujeres, durante ésta se producen alteraciones importantes que repercuten en su salud integral y calidad de vida. La enfermedad periodontal representa un alto impacto en su salud bucal ocasionando en gran medida la perdida de órganos dentales.

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia de enfermedad periodontal y perdida dental en pacientes con menopausia.

MATERIAL / MÉTODOS: Previo consentimiento informado se aplicó una encuesta de filiación, antecedentes menopáusicos y sintomatología bucal, posteriormente se realizó una inspección bucal armada para evaluar tejidos blandos y determinar el índice de presencia de enfermedad periodontal y dientes perdidos a 303 mujeres con diagnóstico de menopausia, con rango de edad de 38 a 69 años, en un centro de salud del Estado de México.

RESULTADOS: Se observó que de las 303 participantes el 51.49% presentó alteraciones periodontales y en mucosa, de esta población un 82.35% presento perdida de órganos dentales, se observaron otras alteraciones como: xerostomía, caries, glosodinia y también se reportó alto deterioro en cavidad oral. Un 45.87% de las mujeres con edades entre 38 a 61 años utilizan prótesis, 36.63% fija y 9,24% removible debido a la perdida dental producida por la enfermedad periodontal.

CONCLUSIONES: Por la alta prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes con menopausia es necesario implementar un diagnóstico y tratamiento odontológico para eliminar los factores que propician esta alteración.

15

IMPORTANCIA DE LA CARIES COMO ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRANSMISIBLE.

ELIZABETH SEGUNDO TOBIAS
elizabethsegundo40@gmail.com
ERIKA HEREDIA PONCE
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN: Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son aquellas que se van a desarrollar lentamente por un periodo de tiempo largo, no tiene cura, pero si un tratamiento una vez que se diagnostican y tienen factores de riego comunes modificables para su prevención, son unas de las principales causas de muerte en el mundo antes de los 70 años y afectan principalmente a países de ingreso mediano a bajo.

OBJETIVOS: Conocer la importancia de la caries dental como una enfermedad crónica no transmisible (ECNT).

MATERIAL / MÉTODOS: Se llevó a cabo una revisión de la literatura.

RESULTADOS: Los factores comunes entre las ECNT y la caries dental están el consumo excesivo de agentes nocivos para la salud, consumo excesivo de azúcares, falta de consumo de agua sin saborizantes y mala técnica de cepillado dental, sedentarismo y una educación para la salud deficiente. En mayo del 2019 la FDI y la IADR firmaron una declaración conjunta para incluir a la caries dental dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles.

CONCLUSIONES: La importancia de incluir a la caries dental como ECNT es el control y la prevención, la mejoría para el acceso al diagnóstico tratamiento y prevención.

17

CONOCIMIENTOS Y CONDUCTAS DE LOS CIRUJANOS DENTISTAS DE PRÁCTICA GENERAL Y CIRUJANOS ORALES ANTE LA PRESCRIPCIÓN PROFILÁCTICA Y TERAPÉUTICA DE ANTIBIÓTICOS

LUIS JAVIER MARCOS VELAZQUEZ
javier.marcos@uicui,edu.mx
JULIO CESAR BERMÚDEZ BARAJAS, PIERRE GONZÁLEZ DIÁZ, ELIZABETH SÁNCHEZ GUTIÉRRES
UNIVERSIDAD DE IXTLAHUACA CUI
LICENCIATURA DE CIRUJANO DENTISTA

INTRODUCCIÓN: La resistencia bacteriana a los antibióticos (RBA) es un problema de salud pública. Se ha señalado al gremio odontológico como una de las ramas médicas que mayor uso hacen de los antibióticos, prescribiendo al menos 10% del total de las indicaciones alrededor del mundo.

OBJETIVOS: Evaluar el conocimiento y las conductas de los participantes sobre la prescripción de antibióticos ante una extracción dental simple y quirúrgica.

MATERIAL / MÉTODOS: Se desarrolló un estudio descriptivo transversal a una muestra de 111 participantes, mediante la aplicación de una encuesta a Cirujanos Dentistas y Cirujanos Orales del estado de México de la base de datos de ADEMAC a través del sitio web Google Forms. El desarrollo de la encuesta se basó en 4 artículos de PubMed relacionados con el uso de antibióticos en odontología.

RESULTADOS: El 98.2% de los participantes indicaron que prescriben antibióticos y por otra parte el 83.3% de los encuestados respondieron que sí conocen el protocolo para una profilaxis antibiótica adecuada de la AHA, aunque solo el 68% (gráfica 1) respondió correctamente cuando se les preguntó. Además, el 43.2% de quienes respondieron la encuesta indicaron que siempre emplean antibioticoterapia cuando realizan extracción dental quirúrgica. El absceso periapical agudo resultó ser la causa más frecuente de prescripción entre los participantes como se muestra en la gráfica 2.

CONCLUSIONES: El conocimiento de los Cirujanos Dentistas y Cirujanos Orales del Estado de México, aún no es óptimo para colaborar en la contención de la resistencia bacteriana.

18

PREVALENCIA DE DEFICIENTE HIGIENE ORAL, CARIES CAVITADAS Y NO CAVITADAS EN UN GRUPO DE ESCOLARES DE 6 AÑOS EN TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO

RAYMUNDO PAREDES BRAVO
raymundo07@gmail.com
MARÍA FERNANDA VAZQUEZ ORTÍZ, ALVARO GARCIA PEREZ, ÁLVARO EDGAR GONZÁLEZ ARAGÓN PINEDA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

INTRODUCCIÓN: Si bien la caries dental es una enfermedad de origen multifactorial y su desarrollo depende de la interrelación entre la superficie de los dientes, los carbohidratos de la dieta y las bacterias específicas, uno de los principales factores asociado a su aparición es una inadecuada higiene oral.

OBJETIVOS: Estimar la prevalencia de deficiente higiene oral y caries en escolares de 6 años de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio transversal, en una muestra por conveniencia de escolares de 6 años de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Para la variable higiene oral, se utilizaron los valores para desechos blandos del índice de higiene oral simplificado (IHO-S = aceptable 0.0-1.8/ deficiente 1.9-3.0). Para la variable caries se utilizó el índice ICDAS II (International Caries Detection and Assessment System), con los códigos 1-3 para caries no cavitadas y del 4-6 para cavitadas.

RESULTADOS: Se examinaron los dientes temporales de 236 escolares con una media de edad de 6.08 ±0.42 años, de los cuales el 55.5% (n=131) fueron mujeres. La prevalencia de higiene oral deficiente fue del 20% (n=47), en cuanto a la prevalencia de caries, un 14% (n=34) presentó con caries no cavitadas (CDASII = 1–3) y el 80% (n=188) con caries cavitadas (CDASII = 4–6). Los escolares con deficiente higiene oral presentaron mayor prevalencia de caries cavitadas (91.5% vs 76.7%; p=0.04). El sexo fue independiente de la prevalencia de pobre higiene y caries (p>0.05).

CONCLUSIONES: A pesar de que solo una 1/5 de la muestra presentó higiene oral deficiente, estuvo asociado con presentar mayor prevalencia de caries cavitadas en este grupo de edad.

19

ÍNDICE DE CPO EN PACIENTES CON DIFERENTES TIPOS DE TRASTORNO AUTISTA

MARÍA ELENA GONZÁLEZ ARREAGA
mareunam@hotmail.com, cesar18031994@gmail.com
CÉSAR FABIÁN LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ VILLANUEVA, MANUEL RUBÍN GONZÁLEZ, GABRIEL MARTÍNEZ CARILLO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

INTRODUCCIÓN: El autismo es un conjunto de alteraciones del neurodesarrollo, inicia en la infancia, implica alteraciones en: comunicación, interacción social, comportamientos y actividades. No existen manifestaciones bucales específicas en pacientes autistas, aunque se han identificado ciertas características frecuentes como el bruxismo, maloclusiones, caries dental y problemas periodontales.

OBJETIVOS: Determinar el índice de CPO en pacientes con diferentes tipos de trastorno autista.

MATERIAL / MÉTODOS: Se entrevistaron a 301 pacientes de la clínica de autismo de la CDMX en el Centro de Salud “Galo Soberón” que presentan diagnóstico de algún tipo de Trastorno del espectro autista (TEA), previo consentimiento informado se realizó un examen bucal por área, registrando el índice de cariados perdidos y obturados (CPO), se aplicó un cuestionario evaluando el tipo de trastorno autista y se realizó el análisis de datos en Excel obteniendo porcentajes de las variables del estudio.

RESULTADOS: De los 301 participantes 83.72% son del sexo Masculino y 16.28% femenino, el rango de edad es de 2 a 26 años con una moda de 6 años en 16.94%. Tipo de Trastorno del espectro autista: Autismo 50.17%, Trastorno desintegrativo de la infancia 1.33%, Síndrome de Asperger 17.28%, Trastorno generalizado del desarrollo (no especificado) 3.99% y TDAH 27.24%. El índice CPO registró los siguientes datos. Sin caries 57.14%, 12.62% un diente cariado, 10.30% dos dientes cariados. 82.06% no presentan obturaciones, 88.37% no presentó perdida de dientes, 11.63% presento al menos una perdida dental.

CONCLUSIONES: Se observo poca presencia de caries en la población examinada a pesar del trastorno autista, esto se debe al cuidado de los padres en la salud integral del paciente.

20

EFICACIA DE ENJUGUES BUCALES BLANQUEADORES SOBRE ESMALTE DENTAL EVALUANDO RUGOSIDAD Y COLOR

ROSALINDA JOSELINE LOZA ORNELAS
loorjlo14@gmail.com
CECILIA CARLOTA BARRERA ORTEGA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

INTRODUCCIÓN: Los dientes blancos son prioridad para algunos pacientes existen diferentes productos de venta libre como, pastas, geles, bandas y enjuagues. Hay poca evidencia de productos blanqueadores dentales además de los utilizados en consultorios dentales.

OBJETIVOS: Determinar la eficacia de tres enjuagues bucales blanqueadores sobre esmalte dental desmineralizado con refresco de cola evaluando rugosidad de superficie y cambio del color.

MATERIAL / MÉTODOS: 90 terceros molares inferiores/retenidos, corte mesio-distal para obtener 180 superficies (n=30 c/u): SO grupo LW (Luminous-White Colgate®), grupo 3DW (3D-Whitening Oral-B®), grupo WE (Whitening-Extrem Listerine®), grupo Lesión Inicial (LI) a todos se les realizó lesión inicial (96h-pH 2.8), un grupo esmalte sano (ES). Fueron sometidos a pH-cíclico alternando inmersión en refresco de cola (pH 2.8-1.5h) y saliva artificial (pH 7.0-22.5h) GraphPad-8.5.

RESULTADOS: La Ra y DE presentaron diferencias significativas entre: SOvsLW con $p \leq 0.0176$, SOvs3WE, WEvs3WE, LWvs3WE con una $p<0.0001$. Los resultados de color presentaron diferencias significativas entre SOvsWE, SOvsLw y SOvs3WE con un valor de $p<0.0001$. El WE fue el menos rugoso (0.69), después LW (0.74), y 3DW (0.92), en el color el 3WE obtuvo el color más blanco (10.83±0.1), después WE (11.9±1.1), luego LW (12.2±1.5), finalmente 38.3±3.1).

CONCLUSIONES: El 3WE obtuvo el mejor efecto blanqueador, sin embargo, fue el más rugoso debido a la pérdida mineral del esmalte, en contraste el LW obtuvo menor efecto blanqueador.

21

EVALUACIÓN IN VITRO DE LA DUREZA DEL ESMALTE DENTAL DESPUÉS DE APLICAR 3 BARNICES REMINERALIZANTES

CECILIA CARLOTA BARRERA ORTEGA
cbarrera@unam.mx
KARLA ITZEL PINEDA DOMINGUEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

INTRODUCCIÓN: La caries es un problema de salud pública mundial y en México afecta al 85% de la población de niñas, niños y adolescentes, una manera de prevenirla es la aplicación de barnices fluorados remineralizantes sobre lesiones incipientes para revertir la caries dental.

OBJETIVOS: Evaluar la dureza del esmalte dental después de colocar tres barnices fluorados con efecto remineralizante en lesión incipiente de caries in vitro.

MATERIAL / MÉTODOS: 150 superficies terceros molares inferiores, divididos aleatoriamente: Lesión Inicial, Flúor-Protector-Ivoclar™, Clinpro-White-Varnish-3M™, Duraphat, Colgate® se realizó lesión inicial (inmersión solución desmineralizante pH 4.4_96h), excepto Esmalte Sano. Todos los grupos fueron sometidos a pH cíclico, 3h en solución desmineralizante, 21h en remineralizante (pH 7.0) aplicando barnices diariamente, durante 5, 10 y 15 días. Se realizaron indentaciones (durómetro-Vickers). Se realizó Kruskal-Wallis y Wilcoxon ($p<0.05$) GraphPad 8.5.

RESULTADOS: El número de dureza fue (HVN) ES 315.0(±10.2), LI 281.0(±4.1), CDu_5d 344.5(±6.2), CDu_10d 352.5(±11.6), CDu_15d 483.0(±13.0), VCP_5d 448.2(±9.8), VCP_10d 406.3(±22.0), VCP_15d 473.6(±12.7), FP_5d 80.0(±9.3), FP_10d 62.5(±6.1) y FP_15d 40.0(±1.9) donde si hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupos del barniz FP con respecto a los demás grupos.

CONCLUSIONES: El grupo tratado con el barniz CDu y VCP si aumentan la dureza del esmalte dental, incluso más que el grupo ES, LI y FP.

22

COMPARACIÓN DE PIGMENTACIONES EXTRÍNSECAS DEL ESMALTE DESMINERALIZADO UTILIZANDO TRES GOMAS DE MASCAR

MARIO IVÁN GARCÍA VALENZUELA
mariovalenzueladks@gmail.com
CECILIA CARLOTA BARRERA ORTEGA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

INTRODUCCIÓN: La tinción extrínseca de los dientes resulta de la deposición de pigmentos sobre esmalte, se originan por consumo de refrescos y la dieta, estudios clínicos han demostrado la eficacia de algunas gomas de mascar para eliminar manchas extrínsecas además de remineralizar el esmalte dental.

OBJETIVOS: Determinar la eficacia de tres gomas de mascar para eliminar pigmentaciones extrínsecas sobre esmalte dental desmineralizado con refresco de cola, evaluando rugosidad y color.

MATERIAL / MÉTODOS: 150 superficies terceros molares inferiores, divididos aleatoriamente en: Lesión Inicial, TEC (Trident®), CPX (Curaprox®), ORB (Orbit®) sometidos a pH cíclico alternando inmersión en soda (pH 2.8-1.5h) y saliva artificial (pH 7.0 22.5h) dos inmersiones diarias con el machacado de la goma de mascar, en intervalos de 6h, durante 5, 10, 15 días. La rugosidad se midió con perfilometría óptica, el color, con Pro-ColorSpec™, ANOVA(2-vías), Tukey ($p<0.05$) GraphPad 8.5.

RESULTADOS: En color la media y DE fueron: ES 4.1(±0.4), LI 27.9(±2.2), TEC_5d 11.1(±0.6), CPX_5d 12.3(±0.9), ORB_5d 18.9 (±1.4), TEC_10d 20.3(±1.2), CPX_10d 15.1(±0.6), ORB_10d 10.95(±0.2), TEC_15d 15.70(±0.6), CPX_10d 18.1(±0.7) y ORB_15d 15.4(±0.2). En rugosidad El grupo TECvsORM si presentó diferencias significativas $p<0.0288$.

CONCLUSIONES: El uso de gomas de mascar dos veces al día, si elimina las pigmentaciones extrínsecas y si modifica la superficie del esmalte dental desmineralizado con refresco de cola.

23

CREENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES SOBRE LA SALUD ORAL DE PREESCOLARES.

ERNESTO ISMAEL MÁRQUEZ SANTANA
marquezag97@gmail.com
MIGUEL Á. QUIROGA, GUILLERMO CRUZ PALMA, CARLOS GALINDO LARTIGUE, GUSTAVO I. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CRISTINA SIERRA SAAVEDRA, PAULA I. PALOMARES GORHAM.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN: En México la caries sigue siendo una de las principales enfermedades que afecta a la población ya que se presenta a edades tempranas. Los preescolares presentan más vulnerabilidad por lo que el análisis de sus posibles factores es vital para su control.

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia de creencias sobre salud oral de padres de familia. • Identificar el principal responsable del cuidado oral del prescolar.

MATERIAL / MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal comparativo en el cual se utilizó una adaptación de la escala de creencias de Nakazono (la cual adopta las dimensiones del modelo de creencias en salud) a padres de familia de niños de hasta 72 meses en 8 jardines de niños de Guadalupe Nuevo León. La selección de los sujetos de estudio se realizó por conveniencia (no probabilística).

RESULTADOS: En la escala de creencias en salud se observó que la mayoría de los padres tenían creencias favorables (94%) sobre el cuidado de salud oral de su hijo y solo una cantidad menor presentaba creencias desfavorables (6%); por otra parte, la madre se observó en más de la mitad de los casos, como la principal responsable de la salud oral del hijo (53%).

CONCLUSIONES: Se hace indispensable la educación en salud oral a los padres. Se debe incluir a los padres en programas y acciones encaminadas a prevenir la caries infantil.

24

EFECTO DE MUSICOTERAPIA BINAURAL 8D PARA DOLOR Y CONDUCTAS NEGATIVAS EN ODONTOLOGÍA.

ROBERTO PIÑEYRO LUNA
rpineyro93@hotmail.com
MIGUEL Á. QUIROGA GARCÍA, GUILLERMO CRUZ PALMA, PAULA I. PALOMARES GORHAM, CARLOS GALINDO LARTIGUE, GUSTAVO I. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, CRISTINA SIERRA SAAVEDRA.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN: La musicoterapia tiene un efecto terapéutico que actúa en las ondas cerebrales tipo alfa, las cuales se asocian a los estados de relajación. Se valoró su uso y eficacia para en el manejo del paciente.

OBJETIVOS: Analizar la eficacia de la musicoterapia binaural en 8D como terapia alternativa durante la consulta dental.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio transversal, participaron 60 pacientes de ambos sexos. Se les realizaron obturaciones de resina y/o amalgama bajo consentimiento informado. Fueron expuestos a la musicoterapia binaural en 8D por medio de su smartphone, auriculares y una playlist de Spotify. Se evidenció bajo frecuencia cardiaca con 3 tomas de presión arterial. La primera toma fue 5 minutos antes del tratamiento (sin musicoterapia), la segunda a mitad de tratamiento (bajo musicoterapia) y la tercera faltando 5 minutos para concluir el tratamiento (bajo musicoterapia).

RESULTADOS: 98% de los pacientes tuvo una disminución en su presión arterial de la primera toma a la segunda toma, evidenciando, además, mayor disminución en la tercera toma de presión. Del 98%, el 58% presenció relajación, 13% satisfacción, 17% sueño, 10% tranquilidad y 2% estrés. Además, la música influyó en el dolor dental, reduciéndolo en el 73%, mientras que el 26% no presentó dolor y en el 1% permaneció igual.

CONCLUSIONES: La musicoterapia 8D es eficaz en el manejo de conductas negativas, evitando así el uso de prescripción de fármacos y brindando integridad.

25

CONOCIMIENTOS DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA DE CIRUJANO DENTISTA. PROYECTO PAPIME PE200722

OLGA TABOADA ARANZA
olga.taboada@zaragoza.unam.mx
ROSA DIANA HERNÁNDEZ PALACIOS, ALEJANDRA GÓMEZ CARLOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN: Para Sánchez-Puentes "…quien forma investigadores no trabaja para el corto sino para el mediano y largo plazo, porque son diversos los saberes teóricos, prácticos, las estrategias, habilidades y destrezas que el investigador que se inicia tiene que asimilar y en las que se tiene que capacitar".

OBJETIVOS: Determinar el nivel de conocimientos que de metodología de la investigación tiene una población de estudiantes de la licenciatura de Cirujano Dentista.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio observacional, prolectivo, transversal y descriptivo en 281 estudiantes de la licenciatura de Cirujano Dentista, 29% (82) del sexo masculino y 71% (199) del femenino; edad media 21.0 (± 1.8) años. Se les aplicó el cuestionario "Nivel de conocimientos de la metodología de la investigación que tienen los estudiantes de la licenciatura de Cirujano Dentista".

RESULTADOS: La calificación para el total de los estudiantes fue de 6.5 (± 1.4); el mayor número de respuestas incorrectas son las referentes a la investigación documental; se diseñaron cinco ítems sobre variables, la calificación obtenida por los estudiantes en esta sección fue de 5.4 (± 2.4), estas preguntas son esenciales en investigación por lo que se considera que el conocimiento de este rubro es insuficiente.

CONCLUSIONES: La metodología de la investigación es básica en la clínica, se hace necesario consolidar su enseñanza a través de competencias prácticas.

26

PERCEPCIÓN DE LOS PASANTES DE LA CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA HACIA LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. PROYECTO PAPIME PE200722

OLGA TABOADA ARANZA
olga.taboada@zaragoza.unam.mx
ALEJANDRA GÓMEZ CARLOS, ROSA DIANA HERNÁNDEZ PALACIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN: La investigación científica tiene como objetivo la generación de conocimientos para la solución de problemas prácticos, es esencial en la formación profesional del Cirujano Dentista, promueve en ellos habilidades cognitivas características del pensamiento crítico lo que amplía la frontera del saber.

OBJETIVOS: Conocer la percepción que de Metodología de la Investigación tienen los pasantes en servicio social de la Licenciatura de Cirujano Dentista.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio observacional, prolectivo, transversal, descriptivo, en 284 pasantes, 69% (196) del sexo femenino y 31% (88) del masculino, con una media de edad de 23.9 (± 3.1) años, a los que se les aplicó el cuestionario Índice de Actitud hacia la Investigación adaptado de Rojas y cols. (2012) el cual presenta una α de Cronbach de 0.88. Rojas-Betancur H y cols. Índice de actitud hacia la investigación. Entramado. 2012.

RESULTADOS: El 11% (30) reporta no estar satisfecho con el nivel académico y científico recibido versus el 17% (49) que lo considera bueno; el 42% (119) reconocen que los profesores no exigen normas metodológicas para los trabajos académicos; el 20% (56) manifiesta que es buena la preparación que sus profesores tienen en investigación científica. Para el 67% (191) es regular la forma en que los docentes exponen en clase sus propios trabajos de investigación. El 21% (61) de los pasantes piensa que la formación en investigación es buena para su vida profesional para el 13% (36) mala.

CONCLUSIONES: La percepción de los pasantes de la enseñanza de la metodología de investigación permite determinar las limitaciones del currículo y del proceso enseñanza-aprendizaje.

27

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL SOCIOECONÓMICO Y CARIES EN LA DENTICIÓN TEMPORAL

PEDRO ANTONIO TELLEZ GARCIA
lpsaenz@correo.xoc.uam.mx
LAURA PATRICIA SÁENZ MARTÍNEZ, LEONOR SÁNCHEZ PÉREZ, MA. DEL CARMEN OSORNO ESCAREÑO, JOSÉ MARTÍN NÚÑEZ MARTÍNEZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA XOCHIMILCO
ESTOMATOLOGIA

INTRODUCCIÓN: La OMS en 2017 publicó que más de 530 millones de niños tenían caries en dentición temporal. En México la Secretaría de Salud reportó en 2019 prevalencia de caries a la edad de 2 años de 47.6%, por ser esta enfermedad multifactorial puede estudiarse a través de nivel socioeconómico.

OBJETIVOS: Determinar la relación del nivel socioeconómico con caries en dentición temporal.

MATERIAL / MÉTODOS: Tipo de Estudio: transversal y descriptivo. Población: Infantes de Centros de Desarrollo Infantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la C.D.MX. en edades de 3-36 meses. Datos: género, fecha y nacimiento a término, situación socioeconómica, obtenida por ingreso indirecto (WILSA). Diagnóstico de caries: se realizó en un espacio cerrado, utilizando espejos dentales (OMS) por dos examinadores calibrados. Análisis: con el programa SPSS se determinaron medidas de tendencia central y dispersión y tablas cruzadas.

RESULTADOS: Población: 56 niñas y 50 niños, con edad de 18.63±9.153 meses, el 94.6% no presentó caries y el CPOD fue de 0.13+/-0.597. En la relación caries y nivel socioeconómico, los bebés de 13-24 meses presentaron los valores más altos en bajo ingreso (50%), para mediano ingreso el 44% y para 25-36 meses 50% con alto ingreso. En las niñas sólo el 2.1% presentó caries en el nivel socioeconómico bajo y los niños tuvieron caries en los tres niveles, siendo el mayor nivel el bajo (4.5%).

CONCLUSIONES: La presencia de caries fue mayor en ingreso alto (14.3%) y libres de caries dominó el ingreso mediano (96.2%).

28

MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA PARA EVALUAR LAS DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS MANDIBULARES ENTRE PATRONES ESQUELETALES UTILIZANDO CONE BEAM

GERARDO MARTINEZ SUAREZ
drsgema@yahoo.com.mx
LUIS PABLO CRUZ HERVERT, S. AÍDA BORGES YAÑEZ, ALEJANDRA RENATA BAEZ SALDAÑA, VIVIANA TORO IBACACHE
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

INTRODUCCIÓN: La morfología mandibular en las poblaciones modernas podría ser el resultado de las diferentes maloclusiones relacionadas con el biotipo facial. En ortodoncia existen diferentes formas de evaluar la mandíbula, pero en la actualidad el uso de la tomografía computarizada tiene alta precisión y confiabilidad.

OBJETIVOS: Evaluar la morfología externa de la mandíbula afectada por diferentes maloclusiones y comparándolas con mandíbulas de sujetos con normoclusión.

MATERIAL / MÉTODOS: Para evaluar la mandíbula se realizaron reconstrucciones tridimensionales a través de segmentación manual. Usando estas reconstrucciones 3D, se identificaron 32 puntos fiduciales determinados por coordenadas X, Y y Z y guardados como archivo (.fcsv). Combinamos técnicas para evaluar la forma de la mandíbula entre patrones esqueletales y biotipos faciales, mediante morfometría geométrica. Se realizaron pruebas de normalidad multivariante, análisis de comparaciones múltiples, post hoc DSH Tukey,de componentes principales (ACP) y de varianza canónica (CVA).

RESULTADOS: Analizamos 30 CBCT de individuos entre 10 y 44 años (17 mujeres y 13 hombres, media de edad 23±5.2 [años/meses], 10 con oclusión armónica, 10 clase II y 10 clase III). Segmentamos 30 mandíbulas (9 braquifaciales (30%), 7 dolicofaciales (23%) y 14 mesofaciales (47%) y encontramos que el tamaño mandibular es diferente entre braquifaciales y dolicofaciales, ($p=0.041$) y entre mesofaciales y dolicofaciales, ($p=0.010$). además observamos que los primeros 6 componentes principales (ACP) de la mandíbula explican 76.2 % de la varianza total, solo CP1 y CP2 muestra una ligera separación entre los grupos.

CONCLUSIONES: La morfología de la mandíbula en humanos muestra un amplio rango de variación, podría relacionarse con otros factores como la genética y la nutrición.

29

"EFECTIVIDAD DEL DISPOSITIVO GUARDA OCLUSAL, DESDE LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE"

ADABELLA ARELY CRUZ ARELLANO
adabellacruzarellano@gmail.com
GERARDO MARTÍNEZ SUÁREZ, MARTHA ELIZABETH TOVAR MARTÍNEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

INTRODUCCIÓN: El dolor relacionado con los trastornos temporomandibulares (TTM) es un problema común en las sociedades modernas y el uso de guarda oclusal ha demostrado una alta efectividad.

OBJETIVOS: Conocer la efectividad del guarda oclusal en la reducción de signos y síntomas de la disfunción temporomandibular desde la perspectiva del paciente.

MATERIAL / MÉTODOS: Se seleccionaron participantes con diagnóstico de trastorno temporomandibular, determinado por el formato (CIE10) del Hospital Regional de Ixtapaluca, clasificados y agrupados por edad. Dos ortodoncistas calibrados aplicaron el instrumento tipo Likert a todos los participantes, posteriormente realizaron registros clínicos, radiográficos y de relación céntrica, se elaboró el guarda oclusal, se revisó y ajustó en un periodo de tres meses. Se realizó estadística descriptiva, prueba de Chi2, exacta de Fisher y estadística de McNemar.

RESULTADOS: Analizamos 76 pacientes entre 18 y 69 años. El 85.5% (n=65) fueron del sexo femenino, la media de edad fue de 42±15.9 años. Con respecto a los síntomas articulares al inicio y final de la terapia encontramos reducción de síntomas articulares en mujeres al finalizar la terapia p(≤0.05), encontramos reducción de síntomas en los participantes del grupo 1 n= 19 (14-29 años) y en el grupo II n= 45 (30-59 años), con respecto al alivio de los síntomas y la probabilidad de recomendar el dispositivo también fue significativo p(≤0.05).

CONCLUSIONES: Podemos concluir que el guarda oclusal tiene una alta efectividad para la eliminación del grupo de síntomas articulares, desde la perspectiva del paciente.

30

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE GERODONTOLOGÍA ENTRE LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNAM.

MARICRUZ GUILLÉN GÓMEZ
maricruzguilleng@gmail.com
ERIKA HEREDIA PONCE
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

INTRODUCCIÓN: En 2022, en México residían 17.9 millones de personas de 60 años o más, lo cual representaba el 14% de la población total. En el área de la educación formar recursos humanos capacitados para la atención de este grupo poblacional resulta relevante.

OBJETIVOS: Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas de Gerodontología entre los alumnos egresados de la Facultad de Odontología, UNAM.

MATERIAL / MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal descriptivo entre los egresados de la FO de la UNAM y alumnos de primer año de las diferentes especialidades de la DEPeI, FO, UNAM. A través de un cuestionario en Google Forms se obtuvo la información para posteriormente ser analizada en el programa SPSS versión demo. Se utilizó estadística descriptiva para cada una de las variables involucradas (sociodemográficas, de conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la Gerodontología).

RESULTADOS: Se obtuvo la información de 192 estudiantes de los cuales el 59.4% estaban inscritos en los seminarios de titulación de la FO y el 40.6% eran alumnos de posgrado. El 75.4% eran mujeres y el 26.6% hombres. El 50.5% mencionó tener conocimientos suficientes para la atención de las personas mayores, el 78.6% considera que el adulto mayor debe ser tratado como paciente especial principalmente por la presencia de comorbilidad, polifarmacia, cambios fisiológicos, poca paciencia, horarios de atención y condiciones bucodentales agravadas. El 48.4% considera que el Cirujano Dentista de práctica general no está capacitado para la atención de este grupo poblacional debido a que no hay una asignatura que los forme para la atención, escasa práctica clínica y bases farmacológicas y poca sensibilidad y habilidades para el trato de los pacientes.

CONCLUSIONES: Formar recursos humanos en el área de la Gerodontología contribuirá a la mejor atención de los pacientes adultos mayores encaminando al envejecimiento sano.

31

FRECUENCIA DE CONSONANTES EN MALOCLUSION DENTAL

LETICIA OROZCO CUANALO
letyocu@yahoo.com
MARCO ANTONIO CARDOSO OMEZ, GLORIA MARINA MORENO BAENA
FES ZARAGOZA
CIRUJANO DENTISTA

INTRODUCCIÓN: La dislalia es una alteración de la articulación del habla producida por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios, ya sea por la ausencia de algunos sonidos o por la inserción, distorsión o sustitución de unos fonemas. Causas control en la psicomotricidad fina.

OBJETIVOS: Identificar las consonantes que están relacionadas con las maloclusiones de acuerdo Angle.

MATERIAL / MÉTODOS: Para la realización de trabajo en equipo se realizó la siguiente metodología: Se registro el tipo de maloclusión descritas por Angle y se realiza la prueba de Melgar para la detección de problemas del habla. La prueba de Melgar en idioma español consiste en 56 sustantivos que se usan comúnmente en la conversación cotidiana de las personas de habla española.

RESULTADOS: Se examinaron 164 sujetos, de los cuales en Clase I se presentaron omisión en los fonemas en P 34%, B 26%, sustitución en F 12%, M 28%, g 36%, k 23%, distorsión en X 18%, en clase II T 15%, D 56%, distorsión en S 45%, N 30%, y en clase III distorsión en D 83%, L 86%. Las diferentes maloclusiones de acuerdo con la edad donde se ve que a los 6, 11, 12 y 16 años en clase III.

CONCLUSIONES: Se examinaron 164 sujetos que acudieron a la Clínica Universitaria de Atención a la Salud Zaragoza, de los cuales en Clase I se presentaron omisión en los fonemas en P 34%, B 26%, sustitución en F 12%, M 28%, g 36%, k 23%, distorsión en X 18%, en clase II T 15%, D 56%, distorsión en S 45%, N 30%, y en clase III distorsión en D 83%, L 86%. Las diferentes maloclusiones de acuerdo a la edad donde se ve que a los 6, 11, 12 y 16 años presencia de clase III. Los pacientes con Clase III presentaron mayores problemas de dicción con las letras d.

32

FACTORES ASOCIADOS CON LA AUTOMEDICACIÓN EN NIÑOS CON SÍNTOMAS DE ORIGEN BUCODENTAL

FRANCIA MICHEL AGUILAR GARIBAY
freench.ga@gmail.com
TATIANA DINHORA MONDRAGÓN BÁEZ, FEDERICO MORALES CORONA, MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ TRUJILLO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN

INTRODUCCIÓN: La automedicación “por poderes” (APP) es la medicación dada a un menor por parte de un apoderado sin la prescripción de un profesional de la salud. Esta práctica tiene efectos adversos potenciales difíciles de prever, así como factores que la condicionan.

OBJETIVOS: Determinar los factores asociados con la APP en familias con niños que hayan padecido malestares dentobucales en México durante mayo 2021- junio 2022.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio transversal realizado con cuidadores mexicanos de niños entre 0-14 años durante 2021-2022. Muestreo no probabilístico por conveniencia. Se evaluaron características sociodemográficas, malestar bucal y APP con el instrumento en español utilizado por Valenzuela (2017). El cuestionario se difundió mediante sociales. Se calculó la media y desviación estándar para variables cuantitativas, así como frecuencias y porcentajes para cualitativas. El análisis bivariado se realizó con X^2.

RESULTADOS: Participaron 164 cuidadores con una media de edad de 33.28±6.41 años, principalmente casadas (70.1%) con licenciatura (41.5%) y un solo hijo (43.9%). Se encontró que de los menores que presentaron malestar, solo en 22.1% no fueron automedicados. El 66.2% fue automedicado con analgésicos, el 10.3% con antibióticos y el 1.5% con otro medicamento. Se encontró asociación estadística significativa entre la APP y el número de hijos ($p=0.021$) y así como la dosis medicamentosa con la escolaridad de los padres ($p<0.001$).

CONCLUSIONES: Los factores asociados con la automedicación “por poderes” por malestar bucal, son el número de hijos y la escolaridad de los padres.

33

NIVELES DE ANSIEDAD POR COVID-19 EN ALUMNOS DE 7° Y 9° SEMESTRE DE ODONTOLOGÍA EN RETORNO A CLASES PRESENCIALES

ALEJANDRA TIMOTEO RIVERA
alejandra.timoteo28@gmail.com
REYES IVÁN GARCÍA CUEVAS, NORA GUILLERMINA PÉREZ PÉREZ, RAFAEL TORRES TOSAS, CARLOS JOSUÉ SOLÓRZANO MATA, BEATRIZ XOCHITL ÁVILA CURIEL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ''BENITO JUÁREZ'' DE OAXACA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN: La ansiedad se caracteriza por sentimientos de tensión, estrés, preocupación y/o síntomas físicos. La vida universitaria aumenta factores estresantes, como responsabilidad, estudio, socialización y soledad; niveles particularmente altos en estudiantes de odontología. La pandemia favoreció condiciones para desencadenar la ansiedad en estudiantes.

OBJETIVOS: Identificar niveles de ansiedad por COVID-19 relacionado al retorno a clases presenciales en estudiantes de licenciatura 7º & 9º semestre de Facultad de Odontología.

MATERIAL / MÉTODOS: El presente estudio es de diseño transversal comparativo efectuado en diciembre de 2023. Previo consentimiento de los alumnos de 7° y 9° semestre de la facultad se les aplicó el instrumento "Coronavirus Anxiety Scale" (CAS) conformado por 5 ítems de tipo Likert. Se consideró con síntomas de ansiedad un valor ≥ 9. Se incluyeron alumnos de ambos sexos, se excluyeron alumnos con trastorno mental diagnosticado previamente y las encuestas incompletas. Los datos se procesaron con el programa SPSS ver 25.

RESULTADOS: Muestra (149 encuestas), 74.5% mujeres y 25.5% hombres, promedio 22 ±1.3 años, 42.3% derechohabientes y 57.7% no. 5.4% (IC95% 1.8-9.0) manifestaron síntomas de ansiedad (COVID-19). Promedio general CAS 2.9±3.0. El promedio mayor se observó "sensación de estar paralizado o frio al estar expuesto al COVID-19" (0.89±0.9). Manifestaron ansiedad 7° (2.7%) y 9°(8.1%), no significativo p=0.13, por severidad se observó diferencia significativa el 7º puntaje CAS 2.3±2.8 y 9º 3.5±3 p=0.016. Por sexo 5.3% femenino y 5.4% masculino.

CONCLUSIONES: El 5.4% de los estudiantes encuestados manifestó ansiedad por el COVID-19. No se observó diferencia significativa por sexo, por semestre, solo por severidad.

34

CALIDAD DE VIDA Y SALUD BUCAL EN ESCOLARES DE NEZAHUALCÓYOTL

EFRAIN GARCIA MENDOZA
efrain.garcia.mendoza@gmail.com
MARIA LILIA ADRIANA JUAREZ LOPEZ, MARIN MIRANDA MIRIAM
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN: La calidad de vida refiere a satisfacción de un individuo sobre su bienestar biopsicosocial y la salud bucal interviene en bienestar individual y/o familiar. El cuestionario Parenteral/caregivers percepcions aborda la calidad de vida considerando los síntomas y funciones bucales, así como aspectos emocionales y sociales.

OBJETIVOS: Determinar calidad de vida en un grupo de escolares participantes en programa de salud bucal en el municipio de Nezahualcóyotl, periodo escolar 2022-2023.

MATERIAL / MÉTODOS: Se aplicó un cuestionario de 35 preguntas basado en el P-CPQ a los padres o tutores de 50 escolares de una primaria en Cd. Nezahualcóyotl. Todos los participantes tenían experiencia de caries, CPOD>1. Las respuestas se clasificaron con la escala de Likert: 0 = nunca, 1 = una o dos veces, 2 = a veces, 3 = a menudo, y 4= todos los días. Se obtuvo la sumatoria total. Así como los promedios y desviación estándar para cada uno de los cuatro dominios.

RESULTADOS: La media del puntaje global del cuestionario fue 16.15± 11 para niños y 15.6 ±19 para niñas. La distribución por dominio fue: 4.38 ± 4.32 para los síntomas orales; 4.46 ± 5.29 para limitaciones funcionales; 2.48 ± 4.03 en bienestar emocional y 3.58 ±7.2 en convivencia social. El 68% de los niños refirió cuadros de dolor. Y el 77% alteraciones en las funciones bucales. No hubo diferencia entre niños y niñas. P>0.05.

CONCLUSIONES: La experiencia de caries tuvo un impacto bajo en la calidad de vida de los escolares. El dolor y las alteraciones en las funciones bucales se reportaron con frecuencia mayor.

35

NUTRICIÓN Y SU RELACIÓN CON CARIES DENTAL EN PREESCOLARES

MARÌA YOLANDA FLORES HERNÀNDEZ
mayo66964@gmail.com
LAURA P. SÁENZ MARTÍNEZ, LEONOR SÁNCHEZ PÉREZ, MA. DEL CARMEN OSORNO ESCAREÑO, MA. ISABEL LUENGAS AGUIRRE, JOSÉ MARTÍN NÚÑEZ MARTÍNEZ.
UNIVERSIDAD AUTÒNOMA METROPOLITANA XOCHIMILCO
ESTOMATOLOGÌA

INTRODUCCIÓN: El estado nutricional juega un papel importante tanto en el estado de salud general como en el bucal, de ahí la importancia de realizar diagnóstico precoz en edad preescolar para fomentar el desarrollo físico, así como conservar la dentición y sus tejidos de soporte.

OBJETIVOS: Determinar la relación entre caries en dentición primaria y el índice de masa corporal en preescolares.

MATERIAL / MÉTODOS: Tipo de estudio: descriptivo y transversal. Examen clínico: A partir del consentimiento informado se realizó a 100 niños de la ciudad de México de 4 y 5 años en el año 2018 el diagnóstico de caries mediante el índice CPOD (OMS) por dos examinadores calibrados y la medición del IMC (Patrones de crecimiento infantil de la OMS). Análisis estadístico: Se obtuvo estadística descriptiva de cada variable y tablas cruzadas.

RESULTADOS: La población se conformó por 100 niños con edad de 4.93±0.256 años. El índice CPOD fue de 3.40±4.132, y el de nutrición fue: 68% sanos, 17% con riesgo de sobrepeso, 13% sobrepeso y 2% bajo peso. No hubo relación entre salud dental y estado nutricional en preescolares, ya que de las niñas con IMC saludable el 21.6% presentó entre 7 y 14 dientes con experiencia de caries y los niños 12.1%. Respecto al sobrepeso los niños tuvieron 10.1% con afectación entre 7 y 15 dientes y las niñas con 2%.

CONCLUSIONES: Del 68% de la población con IMC saludable sólo 31% no tuvo caries, por lo que es necesario identificar otros factores que expliquen la relación con caries.

36

PRÓTESIS OBTURADORA PARA REHABILITACIÓN DE DEFECTO POR MAXILECTOMÍA PARCIAL. PACIENTE CON HEPATITIS C: CASO CLÍNICO

CECILIA HERNANDEZ MORALES
cehm@yahoo.com
ENRIQUE DÍAZ-PALOMARES, MARÍA DE LOURDES SANDOVAL-RIVAS, ZOILA DELGADILLO-DELGADILLO, MARCO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ, BR. LAURA ANAHIS QUINTERO DELGADILLO, BRENDA MORA ALBA.
FACULTAD DE ODONTOLOGIA UT UADEC

INTRODUCCIÓN: Los defectos maxilares ocurren como resultado de la resección quirúrgica de neoplasias o como resultado de un traumatismo grave pudiendo resultar en una comunicación oroantral, afectando funciones como la deglución, fonación, respiración y estética. La hepatitis C (VHC) causada por virus ARN es responsable de la mayoría de las hepatitis postransfusionales; estrategias terapéuticas, basadas en las características de cada paciente con la administración simultáneamente de interferón y ribavirina han demostrado una máxima eficacia.

OBJETIVOS: Rehabilitar defecto maxilar mediante prótesis parcial removible con obturador y tratamiento periodontal.

MATERIAL / MÉTODOS: Paciente masculino 45 años de edad, acudió a clínica de Periodoncia de la Facultad de Odontología UAdeC, referido de la división de medicina interna de la U.M.A.E. #71, portador de virus hepatitis C (VHC) controlado, en postratamiento de ribavirina en combinación con peginterferon alfa, refirió intervención quirúrgica para remover tumor nasal benigno, presentando comunicación oroantral en el cuadrante superior izquierdo, ausencia de dientes en dicho cuadrante y problemas periodontales.

RESULTADOS: Después del uso de la prótesis con obturador se logró devolver al paciente la función masticatoria y fonética, mejor estética, así como establecer una oclusión balanceada sin sobrecargar el lado afectado mejorando la calidad de vida del paciente.

CONCLUSIONES: La prótesis parcial con obturador permitió al paciente mejorar tanto la fonación como la deglución, estética y su calidad de vida.

ACTIVIDAD ELÉCTRICA NEUROMUSCULAR Y EL NIVEL DE ANSIEDAD Y ESTRÉS EN PACIENTES CON TTM

CLAUDIA IVONNE RODRIGUEZ CASTAÑEDA
dra.ivonnerodriguez@fo.odonto.unam.mx
FERNANDO ÁNGELES MEDINA, JULIO MORALES GONZÁLEZ, ANTONIO GARCÍA ESPINOSA, NICOLÁS PACHECO GUERRERO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN: La etiología de los Trastornos temporomandibular (TTM) es diversa, los factores psicosociales conllevan a una actividad muscular alterada modificando los signos y síntomas de los TTM.

OBJETIVOS: Evaluar el nivel de estrés y ansiedad y la actividad eléctrica neuromuscular en pacientes con TTM del Laboratorio de Fisiología de la DEPel.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio transversal 65 pacientes, el diagnostico de TTM se realizó con Criterios Diagnósticos y de Investigación de TTM. El dolor muscular y articular se evaluó con algómetro (1,5kg/cm2 y Escala Visual Analógica; apertura bucal en milímetros. El nivel de ansiedad y el estrés se midieron con la Escala de Estrés Percibido y el Inventario de Ansiedad de Beck. La actividad eléctrica neuromuscular se determinó por Root Mean Square (RMS) utilizando Electromiógrafo 1.2UNAM-CINVESTAV.

RESULTADOS: La media de apertura bucal 42.13mm, dolor muscular 5.56 y dolor articular 4.73. El nivel de estrés clasifico en bajo 12%, grave 1%, leve 53.85% y moderado 32.31% y el nivel de ansiedad en: moderada 27.69%, muy baja 66.15% y severa 6.15%. El RMS de acuerdo al nivel de estrés (bajo= 97.33µV, grave 36.54µV, leve 92.96µV y moderado 108.66µV); aumenta 60% el RMS (p=0.789); y el nivel de ansiedad (moderada 99.79µV, muy baja 94.88µV y severa 118.6µV); aumenta 23% el RMS (p=0.762).

CONCLUSIONES: La ansiedad severa y estrés moderado presentan desencadenan un alto nivel de actividad eléctrica.

CONCENTRACIÓN DE FLUORUROS EN AGUA DE CONSUMO EN DISTINTAS ESTACIONES DEL AÑO

LUIS ANTONIO ORTIZ LOPEZ
luis.ortiz.dgo@gmail.com
RICARDO GARCÍA GODINA, SERGIO MANUEL SALAS PACHECO, LESLIE KARINA GAMBOA GUERRERO, OSCAR EDUARDO ALMEDA OJEDA, GAMALIEL ORTIZ SARABIA. JOSÉ MANUEL SALAS PACHECO, OMAR ALEJANDRO TREMILLO MALDONADO.
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN: El flúor está en la corteza terrestre formando sales de fluoruros. Estos fluoruros se disuelven en el agua de consumo, aumentando su concentración durante las estaciones del año, existe evidencia de que la concentración del agua fluctúa durante las estaciones del año.

OBJETIVOS: Determinar los niveles de flúor en el agua de consumo de la cuidad de Durango durante las distintas estaciones del año.

MATERIAL / MÉTODOS: El tipo de estudio es prospectivo, observacional y analítico. Se recolectaron muestras en primavera, verano y otoño, seleccionando 28 zonas para la recolección. La cuantificación de flúor se llevó a cabo por medio de potenciometría con electrodo de ion selectivo flúor de la casa comercial ThermoScientific™ FluorOrion™, el procedimiento se realizó por triplicado. El análisis de datos se llevó a cabo por medio de RStudio® realizando las pruebas estadísticas KruskalWallis y U de MannWhitney.

RESULTADOS: Durante la temporada de primavera se obtuvo una concentración media de flúor de 3.81 ppm, con una máxima de 7.08 ppm y una mínima de 1.02 ppm. Durante el verano la media obtenida fue de 3.54 ppm, con rangos de 1.12 - 6.45 ppm. Y para el otoño de 3.34 ppm con rangos de 0.67 - 5.72 ppm. Con el análisis de U de Mann-Whitney se obtuvo una p=0.011 para la comparación de las estaciones de primavera y otoño.

CONCLUSIONES: Se encontraron diferencias significativas en las concentraciones de fluoruros en agua durante las diferentes. La mayor diferenciaría se observó entre la primavera y el otoño.

TORQUE DEL INCISIVO SUPERIOR Y ESTÉTICA DE PACIENTES PRE Y POST ORTODONCIA

MARIO OMAR ESTRADA NEVAREZ
dr.omar.enevarez@gmail.com
MARCELO GÓMEZ PALACIO GASTÉLUM, NOHÉ VARGAS CHÁVEZ, LUIS JAVIER SOLÍS MARTÍNEZ , OSCAR EDUARDO ALMEDA OJEDA, GAMALIEL ORTIZ SARABIA, OMAR ALEJANDRO TREMILLO MALDONADO,CLAUDIA AVITIA DOMÍNGUEZ.
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN: En ortodoncia lo importante es considerar una estética facial equilibrada, las caras son primero. Existen estándares que revelan la relación de factores, grosor del labio superior, tamaño dental, inclinación dental, empujarlos fuera del hueso basal. De allí, la importancia de toma de decisiones del tratamiento.

OBJETIVOS: Evaluar el impacto del torque del incisivo superior y posición vertical en la estética de pacientes no tratados y pacientes tratados ortodóncicamente.

MATERIAL / MÉTODOS: Participaron 18 pacientes duranguenses; 13 femeninos y 5 masculinos con una edad entre 14 a 30 años. Se recolectaron radiografías laterales de cráneo 8x10 horizontales de una base de datos en un gabinete radiológico privado, se realizó el trazado cefalométrico Tweed-Merrifield, ángulo del incisivo central 1-SN, 1- PP en grados, una perpendicular del borde incisal a plano palatino en mm, borde incisal del incisivo central a la comisura labial en mm: Los datos se analizaron con prueba t.

RESULTADOS: Los valores encontrados en el grupo pretratamiento muestran poca diferencia comparados contra las medidas estandarizadas, la medida del incisivo superior a punto sella nasion corresponde a una media de 105.62 ($p>0.05$). En el grupo postratamiento las mediciones fueron menores en comparación al grupo estandarizado a excepción de la medida del incisivo superior a comisura el cual resulto con una media de 3.42 ($p>0.05$). La medición de 1-pp mm resulto ser mayor en ambos casos para pacientes pretratamiento una media de 32.8($p>0.05$) y pacientes postratamiento una media de 33.16($p>0.05$).

CONCLUSIONES: Los pacientes tratados ortodóncicamente presentan perdida de la angulación al plano palatino, aumento en la extrusión incisal y de la distancia del borde incisal a comisura labial.

CONOCIMIENTO DE SALUD BUCODENTAL DE ADULTOS CON HIJOS DE EDAD PREESCOLAR

ÁNGEL DAYAN SOTELO BRITO
lpsaenz@correo.xoc.uam.mx
EDGAR EMMANUEL ESTEVA VALENCIA, BRANDON ENRIQUE MODESTO RODRÍGUEZ, XITLALI NEPOMUSENO SALAS, ÁLAN OMAR VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, HANNIA LIZBET ZAPO MENDOZA, LAURA PATRICIA SÁENZ MARTÍNEZ.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA XOCHIMILCO
ESTOMATOLOGÍA

INTRODUCCIÓN: La importancia de conocer qué tanto saben los padres con hijos preescolares sobre la salud bucodental, proporcionará elementos para reforzar hábitos para conservar la salud bucal desde edades tempranas.

OBJETIVOS: Estimar el conocimiento de salud bucodental en adultos con hijos preescolares.

MATERIAL / MÉTODOS: Tipo de investigación: transversal, prospectivo y descriptivo. Muestra: 84 adultos (73% madres, 27% padres) elegidos por conveniencia, agrupados por edad y escolaridad. Criterios de inclusión: padres/madres con hijos de 3 a 6 años, quienes autorizaron su participación. Recolección: un cuestionario validado se envió por Google Formularios, con 20 preguntas divididas por categorías (caries, prevención, dieta e higiene). La suma de los puntos fue: (buen conocimiento: 1-6 puntos, regular: 7-13 y mal: 14-20). Análisis: Medidas de tendencia central y dispersión, y tablas cruzadas con el programa SPSS (v.25).

RESULTADOS: Promedio de edad: 34.74±7.568 años y la escolaridad más frecuente fue la técnica y/o superior (81%). La categoría de mayor conocimiento bueno fue la dieta con: cuidador, edad y escolaridad (83%), siguiendo la higiene (73%) y la más baja fue prevención (58%). El conocimiento de caries tuvo un nivel regular en todas las variables (58%). La muestra con educación técnica/superior presentó mejor conocimiento en caries y dieta vs. los de educación primaria y éstos mostraron mayor conocimiento sobre higiene (83%).

CONCLUSIONES: Implementar estrategias que permitan concretar el conocimiento sobre salud bucodental, privilegiando la prevención y los hábitos de higiene, así como reforzar la información sobre la formación de caries.

42

RIESGO CARIOGENICO Y EXPERIENCIA DE CARIES EN UN GRUPO ESCOLAR DE NEZAHUALCÓYOTL

NORMA CAROLINA LARIOS ROBLES
noralarios28@gmail.com
MARIA LILIA ADRIANA JUÁREZ LÓPEZ, MURRIETA PRUNEDA FRANCISCO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FES ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN: El riesgo cariogénico se refiere a la probabilidad de que un individuo o población desarrolle nuevas lesiones cariosas o que las presentes progresen a una mayor severidad. Existen diversos instrumentos como el Caries Management By Risk Assessment (CAMBRA) que aborda factores biológicos, sociales y de protección.

OBJETIVOS: Determinar el riesgo cariogénico con relación a la experiencia de caries en un grupo de escolares del municipio de Nezahualcóyotl.

MATERIAL / MÉTODOS: Se realizó un examen clínico a 65 escolares de 6 y 8 años en una primaria del Municipio de Nezahualcóyotl para determinar los índices CPOD y cpod. Para conocer el riesgo cariogénico se aplicó un cuestionario de 15 preguntas basado en CAMBRA a los padres o tutores. Se consideró como bajo riesgo los puntajes < 5; moderado entre 6 a 7 y alto riesgo > 8.

RESULTADOS: El 38.4% de los escolares fueron niños y el 61.5% niñas. La media del riesgo cariogénico fue de 8.41 y 8.27 respectivamente, $p>0.05$. La higiene dental fue deficiente con un promedio de O´Leary mayor al 30%. El CPOD fue de 0.1 y para el cpod de 6.7. El 52.3% de los niños presentaron un riesgo cariogénico alto y el 47.6% moderado. Nueve de cada diez niños presentó al menos 3 dientes con lesiones cariosas cavitadas con un alto consumo de carbohidratos.

CONCLUSIONES: El riesgo cariogénico fue alto con presencia de múltiples lesiones cariosas, por lo que para mejorar la salud bucal de los participantes es prioritario promover hábitos saludables.

EVALUACIÓN IN VIVO DEL DAÑO NUCLEAR Y OXIDATIVO DEL ADN EN PERSONAS EXPUESTAS A TIRAS DE BLANQUEAMIENTO DENTAL CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 10%

FATIMA MARISOL NAVARRO VILLALON
fatimnv16@gmail.com
SUSANA VANESSA SÁNCHEZ DE LA ROSA, SAULO OSWALDO SÁNCHEZ RIVERA, CRISTINA HERMILA MARTÍNEZ BUGARÍN, BELINDA CLAUDIA GÓMEZ MEDA, CELIA GUERRERO VELÁZQUEZ, MARLENE YVETH ORTIZ GARCÍA, GABRIELA MORALES VELÁZQUEZ, ANA LOURDES ZAMORA PÉREZ.
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ODONTOLOGÍA, DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS INTEGRALES, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD.

INTRODUCCIÓN: La molécula activa empleada para el blanqueamiento dental es el peróxido de hidrógeno (H2O2) y su auto aplicación podría ocasionar la liberación de H2O2 a la cavidad oral poniendo en riesgo al paciente debido a la liberación de radicales libres y su efecto.

OBJETIVOS: Evaluar in vivo el daño nuclear y oxidativo al ADN que causan las tiras de blanqueamiento dental con peróxido de hidrogeno al 10%.

MATERIAL / MÉTODOS: Grupo 1, sin exposición al blanqueamiento dental y grupo 2 con exposición. Se tomaron muestras de mucosa de carrillo, encía adherida y saliva al inicio del estudio. Al grupo 1 se tomó una más a los 30 días y al grupo 2 a los 15 y 30 días. El daño nuclear se determinó con ensayo de anormalidades nucleares en células de mucosa de carrillo y encía adherida y el daño oxidativo en saliva con ELISA.

RESULTADOS: Se observó incremento significativo en el número de ANs en células de mucosa de mucosa bucal de carrillo y encía adherida, así como en la concentración de la molécula 8-OHdG en saliva en el grupo que utilizó el blanqueamiento dental a los 15 y 30 días de muestreo con respecto a la muestra basal.

CONCLUSIONES: El uso de tiras de blanqueamiento dental incrementa el daño nuclear en células de mucosa de carrillo y encía adherida y el daño oxidativo al ADN.

45

RESPUESTA DE UN GRUPO DE ODONTÓLOGOS ANTE EL COVID-19 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

HAZEL DE LA ISLA NEVEU
delihaz@hotmail.com
MARIA ESTHER IRIGOYEN CAMACHO, LEONOR SANCHEZ PEREZ, MARCO ANTONIO ZEPEDA ZEPEDA, CONSUELO VELAZQUEZ ALVA, IRINA LAZAREVICH, HAZEL DE LA ISLA NEVEU, DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA SALUD DIVISION DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD DE UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA XOCHIMILCO.
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA XOCHIMILCO
ESTOMATOLOGÍA

INTRODUCCIÓN: Los odontólogos tienen un alto riesgo de contagio de SARS-CoV2 debido a la cercanía con el paciente y al uso del equipo que emplean para realizar el tratamiento de la cavidad bucal. Las mujeres suelen ser más vulnerables por trastornos emocionales que los hombres.
.
OBJETIVOS: Identificar el impacto emocional del COVID-19 en mujeres odontólogas con práctica profesional en la CDMX, durante la primera ola de COVID-19.

MATERIAL / MÉTODOS: Participaron 151 odontólogas, que respondieron una encuesta en Mayo del 2020. Con preguntas relacionadas con su percepción y conducta ante la pandemia. Explicándoles que al responder el cuestionario indicaban su consentimiento de participar en el estudio. Se realizaron modelos de regresión logística y se obtuvieron las Razones de Momios (RM) para identificar la asociación entre el impacto emocional y su percepción del costo del tratamiento.

RESULTADOS: Las participantes tuvieron un promedio de edad de 41.3 años. La mayoría trabajaba en práctica general (71.5%) y 28.5% en especialidad. La presencia de problemas psicológicos fue identificada por 41.3% de las participantes, incluyendo síntomas de depresión, ansiedad e inestabilidad emocional. El 79.5% tomó medidas adicionales de control de infecciones en casa, 74.8% considera que se aumentó el costo de atención por pandemia. El modelo de regresión logística mostró que las odontólogas con problemas emocionales consideraban el incremento del costo de atención, con aquellas que no presentaban problemas.

CONCLUSIONES: Los problemas emocionales se asociaron con la percepción de incrementos en costo de atención dental. Se requieren programas de salud mental durante etapas críticas en género.

46

ESTUDIO PILOTO DE VALIDACIÓN EN CONFIABILIDAD TRANSVERSAL MAXILAR Y MANDIBULAR EN TOMOGRAFÍAS.

IVONNE ACOSTA BUSTOS
ivonneab1218@gmail.com
LUIS PABLO CRUZ HERVERT
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN.

INTRODUCCIÓN: Las deficiencias transversales del maxilar y la mandíbula son un importante componente de muchas maloclusiones, por medio del análisis de Penn de la Universidad de Pensilvania (Tamburrino y colaboradores, 2010) se puede realizar el diagnóstico con una tomografía Cone Beam.

OBJETIVOS: Identificar la confiabilidad de la dimensión transversal del maxilar y la mandíbula mediante tomografías Cone Beam de la D.E.P. e I. durante el período 2019-2021.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio piloto de un total de 10 archivos tomográficos divido en tres grupos por cada clase esqueletal I, II y III del departamento de Imagenología de la D.E.P. e I. durante el período 2019-2021. Las mediciones se realizaron en dos ocasiones diferentes con un intervalo de tiempo de una semana en cortes axiales y coronales usando el software 3D Slicer del maxilar y la mandíbula según los criterios de inclusión y exclusión; tomando en cuenta las consideraciones éticas de manejo y almacenamiento de los archivos.

RESULTADOS: Se analizaron 10 tomografías con una media de edad para el sexo femenino de 47.62 años (80%) y para el sexo masculino de 33 años (20%); correspondiendo para cada patrón esqueletal I, II y III el 30%, 50% y 20% respectivamente. Se esperaba un valor por encima de 0.80 del coeficiente de correlación intraclase. La distancia transversal en la clase esqueletal I, II y III en la toma 1 y 2 fue de CI1 (3.66 mm ±2.42), CI2 (4.03 mm ±2.11); CII1 (3.76 mm ±3.29), CII2 (3.66 mm ±3.13), CIII1 (2.95 mm ±1.21), CIII2 (4.57 mm ±4.48).

CONCLUSIONES: A partir de nuestros resultados identificamos diferencias entre la discrepancia transversal maxilar y mandibular entre las clases esqueletales de una manera más confiable.

47

EVALUACIÓN DE LOS HÁBITOS DE SUEÑO EN ESCOLARES DE LEÓN, GUANAJUATO DURANTE 2023

RUBEN GARCIA GOMEZ
rubengarciagomez5@gmail.com
MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ TRUJILLO, MARÍA DEL CARMEN VILLANUEVA VILCHIS, ULISES JIMÉNEZ CORREA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD LEON

INTRODUCCIÓN: Los hábitos de sueño (HS) son conductas que favorecen el dormir. Son indispensables para el desarrollo y elaboración de procesos de restauración durante la infancia, sin embargo, sus trastornos pueden verse relacionados con la salud bucal cuando ocurren eventos como el bruxismo del sueño (BS).

OBJETIVOS: Determinar los hábitos de sueño reportados por cuidadores de escolares de una escuela primaria en León Guanajuato durante 2023.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio trasversal realizado en cuidadores de niños de 6-12 años de una primaria en León Guanajuato durante el 2023. Una vez solicitado el consentimiento informado, se evaluaron características sociodemográficas y los HS con el Cuestionario de Hábitos de Sueño en Niños de 22 preguntas validado al español (alfa de Cronbach=081). Se calcularon media y desviación estándar para variables cuantitativas, frecuencias y porcentajes para cualitativas. El análisis bivariado se realizó con X2.

RESULTADOS: Participaron 243 cuidadores con edad promedio de 34.78±8.11 años y ocupación principal hogar (80.7%). La media de edad de los niños fue de 8.51±1.83 años, la mayoría del sexo femenino (51.9%). Se identificó que los niños duermen en promedio 9.10±1.83 horas al día. Solo un 52.3% reportó tomar siestas con duración promedio de 31.23±43.81 minutos. El 32.1% reportó que sus hijos rechinan los dientes al menos una vez a la semana. No se encontró diferencia significativa entre esta última variable con la edad y el sexo.

CONCLUSIONES: La evaluación de los HS es indispensable para identificar posibles factores que condicionan la presencia del BS, para generar estrategias preventivas que incluyan higiene dental como del sueño.

48

ENCUESTA DE SALUD BUCODENTAL CARRERA CIRUJANO DENTISTA EN FES IZTACALA GENERACIÓN 2023

ANGELICA PEÑA GONZALEZ
angelica.pe.glez.22@gmail.com
JUANA JIMENEZ FEREZ
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

INTRODUCCIÓN: Las enfermedades orales constituyen un gran problema de salud pública y realizar encuestas de salud bucodental ayuda a obtener información acerca del estado bucodental de la población. La caries y enfermedad periodontal afectan a gran parte de los habitantes en México debido al cuidado bucal deficiente.

OBJETIVOS: Examinar el estado de salud bucodental y las necesidades de tratamiento de los alumnos que cursan la carrera de Cirujano Dentista en FES Iztacala.

MATERIAL / MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal y descriptivo, basado en la encuesta básica de salud bucodental de la OMS, se utilizaron barreras de protección, espejo dental plano y sonda periodontal.

RESULTADOS: Se encuestaron 574 alumnos, 69.3% mujeres y 30.7% hombres. 63.6% se cepillan tres veces al día y 48.1% ha recibido alguna vez aplicación de flúor. El 75.7% presentó fluorosis. El IPC fue 8.3%. Se obtuvo un índice CPOD de 4.6, adquiriendo el valor mayor los cariados con 2.7, seguido de los obturados con 1.9. En el examen de ATM 43% presentaron signos y síntomas. En anomalías dentofaciales 23.2% presentaron máxima irregularidad del maxilar y mandíbula, 34.5% presentaron superposición del maxilar y mandíbula. El 55.9% necesita obturación de fisura.

CONCLUSIONES: El grupo estudiado presentó un alto porcentaje de fluorosis y un incremento en el índice CPOD en comparación con el estudio 2020.

49

CONDICIÓN BUCAL DE PACIENTES CON DIABETES QUE RECIBEN TRATAMIENTO EN CLÍNICA TLAHUAC-UAMX.

ARMANDO GONZALEZ BELTRAN
armand.gon.bel@gmail.com
ISABEL LUENGAS AGUIRRE, ROSA MAYELL DIAZ IGLESIAS, GUSTAVO TENORIO TORRES
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO
UNIDAD XOCHIMILCO

INTRODUCCIÓN: La DM2 es un problema de salud pública, en México el SIVEPAB indica que a nivel nacional aproximadamente 56.8% de la población con diabetes tiene algún signo de enfermedad periodontal, es importante conocer cuáles son sus alteraciones más relevantes a nivel bucal.

OBJETIVOS: Conocer la condición bucal en pacientes con diabetes que acuden a la clínica estomatológica de Tláhuac perteneciente a la UAM-Xochimilco.

MATERIAL / MÉTODOS: El trabajo de investigación pretende identificar la condición de pacientes con diabetes, la investigación realizada es de tipo observacional con nivel descriptivo, el registro de datos fue retro lectivo, esta investigación se realizó bajo criterios de ética. La población a estudiar consto de 46 pacientes que acudieron en el año 2018 a la clínica Estomatológica de Tláhuac de la UAM-Xochimilco, los datos obtenidos se analizaron por integrantes del equipo de investigación mediante el programa SPSS.

RESULTADOS: El 52% de los pacientes tiene diagnóstico de diabetes, de los cuales el sexo masculino tiene predominio con un 54% (13 pacientes) sobre el femenino (11 pacientes). Sin embrago, 10 de los 46 pacientes no contaban con diagnostico por lo cual no fue posible valorarlos estadísticamente. • De la población de pacientes con diabetes el 62.5% (15 pacientes) presentan movilidad dental. • Respecto a la tensión arterial el 20% (5 pacientes) presentaron presión arterial alta y el 80% presento presión arterial normal. • De la población incluida el 75% presenta Enfermedad Periodontal y tan solo el 25% no presenta signos de mencionada enfermedad.

CONCLUSIONES: Es importante el seguimiento estomatológico en pacientes con diabetes debido a que esta constituye un factor de riesgo para padecer enfermedades periodontales, así como otro tipo de comorbilidades.

CONSUMO DE VEGETALES RICOS EN NITRATO MEJORA VARIABLES CLÍNICAS PERIODONTALES

NYDIA YAZMÍN SÁNCHEZ OROZCO
nydia.sanchez0207@alumnos.udg.mx
ALONDRA DEL CARMEN RUIZ GUTIÉRREZ, YESENIA ISAHY PONCE GOMEZ, KARLA VICTORIA MICHEL LECOU, CARMEN DE LA ROCHA MARTÍN DEL CAMPO, YOLANDA FABIOLA MARQUEZ SANDOVAL, LUCRECIA SUSANA CARRERA QUINTANAR
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

INTRODUCCIÓN: Las periodontitis es una enfermedad crónica, inflamatoria, multifactorial que se presenta como respuesta a disbiosis oral debido a la acumulación de placa dentobacteriana. El nitrato (NO3), es un compuesto presente de manera natural en distintos vegetales y que recientemente se ha propuesto como un prebiótico oral.

OBJETIVOS: Evaluar el efecto del consumo de vegetales ricos en nitrato sobre variables clínicas periodontales en pacientes con tratamiento periodontal no quirúrgico.

MATERIAL / MÉTODOS: Se realizó un ECA simple ciego en pacientes con indicación de TPNQ en la especialidad de periodoncia de las clínicas odontológicas de CUCS. Se crearon 2 grupos: grupo control (TPNQ+ dieta habitual) y grupo intervención (TPNQ+ intervención nutricional para consumir ≈350mg de NO3 proveniente de vegetales). Los parámetros clínicos que se miden son: sitios con placa o cálculo (PoC); sangrado al sondeo (SS); profundidad al sondeo (PS) y nivel de inserción clínica (NIC).

RESULTADOS: Al inicio de la investigación no existieron diferencias significativas en las variables clínicas periodontales, ni en el consumo de nitrato al día entre grupos. Posterior a la intervención nutricional se encontró un aumento significativo de 174 mg/NO3 al día($p<0.05$) en el grupo de interés. Al realizar la comparación de las variables clínicas periodontales final vs basal, se encontró que en el grupo intervención, todas las variables (PoC,NIC,PS y SS) tuvieron una disminución significativa, mientras que en el grupo control solo disminuyó de manera significativa PoC y SS.

CONCLUSIONES: El consumo de nitrato proveniente de vegetales puede ser un complemento útil en el TPNQ. Se necesita mayor investigación al respecto para comprobar los beneficios en el periodonto.

51

ASOCIACIÓN ENTRE LOS ESTILOS PARENTALES Y SALUD BUCAL EN PREESCOLARES DE GUANAJUATO

KARLA LIZETH HERNÁNDEZ OROZCO
khernandez5598@gmail.com
JOLANTA ALEKSEJUNIENE, JAVIER DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES TRUJILLO RAMÍREZ, FÁTIMA DEL CARMEN AGUILAR DÍAZ, MARÍA DEL CARMEN VILLANUEVA VILCHIS.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD LEON

INTRODUCCIÓN: La caries es una enfermedad de alta prevalencia sobre todo a nivel escolar. Debido a su carácter multifactorial, deben considerarse los estilos de crianza adoptados por cuidadores, ya que son los principales facilitadores de las condiciones ambientales, dietéticas, actitudinales y de conocimientos que obtendrán los niños.

OBJETIVOS: Determinar la asociación entre estilo parental de cuidadores con experiencia de caries e higiene oral de preescolares de un kínder de León, Guanajuato.

MATERIAL / MÉTODOS: Se realizo un estudio transversal en población de binomios cuidadores-niños de un kínder en León, Guanajuato. Incluyendo la totalidad de la población. Se aplico el cuestionario PSNAQ validado al español, para evaluar el estilo parental. La higiene bucal fue evaluada con el índice OLeary y la experiencia de caries con ICDAS. Se calcularon medidas descriptivas para variables sociodemográficas. Se aplico una prueba ANOVA para la evaluación de cada estilo parental con el porcentaje promedio de biopelícula y experiencia de caries en la dentición decidua.

RESULTADOS: 107 binomios cuidador-niño fueron evaluados con una media de edad en cuidadores de 32.72±7.33 años, y de 4.21±.683 años en los niños. El porcentaje promedio de dientes cariados en los niños cuyos cuidadores seguían un estilo parental autoritativo fue de 13.71±15.69 (en una escala de 12 a 26) mientras que el porcentaje promedio en los niños cuyos cuidadores seguía un estilo parental permisivo fue de 15.4±19.89 (en una escala de 11 a 25). No se observaron diferencias significativas en la higiene bucal y experiencia de caries de acuerdo con cada estilo parental.

CONCLUSIONES: El estilo autoritativo obtuvo valores mayores relacionados a baja experiencia de caries. Es necesario seguir indagando en la influencia del entorno familiar en la salud bucal de infantes.

“ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA CESACIÓN DEL TABAQUISMO”

ANDREA IXCHEL PICAZO TAPIA
andrea.picazo96@gmail.com
MARÍA DEL CARMEN VILLANUEVA VILCHIS, FÁTIMA DEL CARMEN AGUILAR DÍAZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ TRUJILLO
UNAM
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD LEÓN

INTRODUCCIÓN: Los materiales educativos para la salud son herramientas necesarias para la información y orientación de la población. El tabaquismo representa un problema de salud pública con una prevalencia mundial del 24% de la población y es considerado como factor de riesgo de enfermedades crónicas, así como la causa de efectos negativos en la salud oral.

OBJETIVOS: Elaborar material educativo relacionado al consumo de tabaco dirigido a alumnos de odontología de la ENES León para guiar a sus pacientes.

MATERIAL / MÉTODOS: Se recolectó información sobre las intervenciones más efectivas y se crearon documentos dirigidos a los alumnos para apoyar a sus pacientes para la cesación del hábito. Se elaboraron folletos (trípticos) los cuales fueron mostrados a los alumnos del primer año de la licenciatura en odontología de la ENES León, se les envió de forma electrónica un cuestionario de opinión sobre el contenido de los materiales elaborados. Los datos fueron analizados con el programa SPSS 21.

RESULTADOS: Se aplicó una encuesta de opinión a 63 alumnos, estudiantes del primer año de la licenciatura de odontología de la ENES León con una edad promedio de 19.6 +3.1 años de los que 45 fueron mujeres (71.4%) y 18 fueron hombres (26.5%). Más del 50% está totalmente de acuerdo en que la información contenida es útil. Más del 80% usaría los folletos para brindar información y orientar a sus pacientes.

CONCLUSIONES: El material obtenido fue bien aceptado por los alumnos que lo evaluaron y puede ser empleado de forma impresa, digital y es de utilidad para la orientación de los pacientes en cuanto al abandono de este hábito.

53

CREENCIAS DE SALUD BUCAL DURANTE EL EMBARAZO EN MADRES DE LEÓN, GUANAJUATO

MARÍA FERNANDA VÁZQUEZ GUERRA
radicalch35@gmail.com
DENISSE PARADA LONGORIA, RUBÉN GARCÍA GÓMEZ, MONTSERRAT ÁVILA GONZÁLEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ TRUJILLO, MARÍA DEL CARMEN VILLANUEVA VILCHIS, FÁTIMA DEL CARMEN AGUILAR DÍAZ
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEON

INTRODUCCIÓN: Las embarazadas son un grupo vulnerable debido a que pasan por cambios biológicos y psicológicos que repercuten en la boca. Las creencias de la salud bucal durante el embarazo son creadas a partir de experiencias y conocimientos transmitidos generacionalmente que pueden poner en riesgo la salud del binomio materno-infantil.

OBJETIVOS: Determinar las creencias relacionadas a la salud bucal durante el embarazo en madres de pacientes pediátricos de la ENES León durante marzo de 2020.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio transversal en madres de pacientes pediátricos que acuden a la ENES León, en durante 2020. Se seleccionó a la muestra por conveniencia. Se recolectó el consentimiento informado y se evaluaron características sociodemográficas (escolaridad, ocupación, lugar de procedencia y número de hijos) así como CSBE con el “cuestionario de creencias relacionadas con la salud oral de mujeres gestantes” utilizado en Colombia durante 2009. Se calcularon media y desviación estándar para variables cuantitativas y frecuencias y porcentajes para cualitativas.

RESULTADOS: Participaron 27 mujeres con un promedio de edad fue 29.3±5.1 años, con la educación secundaria como nivel máximo de escolaridad (46%), ocupación principal el hogar (86%). El principal lugar de procedencia fue rural (76%) y la cantidad de hijos reportada fue de 2 a 3 (72%). Solo el 15% se encontraba embarazada al momento de la encuesta. El 93% consideró peligroso acudir al dentista durante el embarazo y un 52% mencionó haber tenido movilidad y/o perdidas dentales. El 74% refirió considerar que las enfermedades bucales son heredadas a sus hijos. En cuanto a las creencias se identificó un nivel regular (51.9%).

CONCLUSIONES: Es necesario diseñar estrategias de educación para la Salud respetuosas que ayuden a modificar estilos de vida y creencias que derivan en resultados adversos para la embarazada e hijo.

PRÁCTICAS ALIMENTARIAS DURANTE EL PRIMER ANO DE VIDA DE ESCOLARES EN GUANAJUATO.

AMAIRANI ANELIZ OROZCO PIZANO
amairani.aneliz@gmail.com
ALVARO EDGAR GONZALEZ ARAGON PINEDA, ALVARO GARCIA PEREZ, MARTHA PATRICIA NIETO SANCHEZ.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEON

INTRODUCCIÓN: La organización mundial de la salud (OMS) recomienda que la lactancia materna exclusiva (lme) debería realizarse durante los primeros seis meses de vida, y continuarla posteriormente con alimentos hasta los dos años.

OBJETIVOS: Identificar las prácticas de alimentación durante el primer año de escolares de León, Gto.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio transversal en el cual se incluyó a la totalidad de madres de escolares de 6 a 12 años asistentes a la escuela primaria “Leona Vicario”. se solicitó la firma del consentimiento informado. se recolectaron datos en febrero 2023, a través de un cuestionario estructurado sobre las prácticas de alimentación realizadas dentro del primer año de vida, así como datos sociodemográficos de las madres (edad, escolaridad, ocupación). se realizó análisis descriptivo y bivariado.

RESULTADOS: 232 madres, edad 34.7(+8.0) años, estudios de secundaria 47.1%. el 60.8% reporta haber practicado lme; en promedio la lactancia fue de 8.9(+8.7) meses, la introducción de agua/tés/jugos a la dieta de sus hijos fue a los 5.6(+3.1) meses y a los 6.5(+2.2) alimentos diferentes a leche. la principal fuente de agua fue embotellada (76.0%). las prácticas de alimentación no estuvieron asociadas a ocupación o escolaridad de la madre ($p>0.05$). existió relación entre edad, principal fuente de agua y momento de introducción de alimentos distintos a la leche($p<0.05$).

CONCLUSIONES: En esta población la práctica de alimentación distan de las recomendaciones por la OMS. la edad estuvo relacionada con diversas prácticas de alimentación.

55

PROGRAMA DE HERRAMIENTAS PSICOMUSICALES PARA LA ATENCIÓN DE ANSIEDAD EN ODONTOLOGÍA

MARLYN CAROLINA MENDOZA SÁNCHEZ
marlyn.mendoza@uabc.edu.mx
DR. MIGUEL ANGEL FRAGA VALLEJO, DRA. MARIA GUADALUPE DELGADILLO RAMOS, DR. DAVID ALFREDO HERNÁNDEZ ONTIVEROS, MSP. PATRICIA PRECIADO BÓRQUEZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE MEDICINA Y PSICOLOGÍA

INTRODUCCIÓN: La odontofobia es uno de los trastornos de ansiedad más prevalentes donde los entornos psicosociales desarrollados en consultorios marcan la pauta de la acción hacia el autocuidado bucal en las personas. El uso de la música en medicina es una terapia auxiliar utilizada con resultados altamente satisfactorios.

OBJETIVOS: Documentar la ansiedad dental observada y ofrecer una herramienta práctica para atenderla como propuesta de mejora continua en el modelo de salud bucal actual.

MATERIAL / MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, con una adaptación del método musico terapéutico de Imagen guiada y música de Bonny en la consulta dental del cual participaron 145 adultos del CIAS SUR ISSSTESON en Hermosillo en 2022, cuya evaluación incluye parámetros físicos, verbales y subjetivos. En adición, se recopilaron los discursos, opiniones y experiencias de los participantes para identificar posibles asociaciones en la atención odontológica.

RESULTADOS: El perfil poblacional observado fue en proporción 4 mujeres por cada hombre, de 51 años de edad, con dolor, que requieren tratamientos de tipo endodóntico y protésico, cuyas comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial y diabetes. En la fase preoperatoria, se registró un 70% de participantes con “ansiedad moderada”, que al ser intervenidos con el uso de las herramientas psico musicales durante su atención dental éste disminuyó al 10% clasificándose como “sin ansiedad”, con una percepción de la experiencia muy satisfactoria y con un cambio positivo, mejor que otras visitas.

CONCLUSIONES: El uso de herramientas psico musicales genera efectos diversos en la ansiedad que pueden clasificarse como positivos y propician un entorno neutral para hacer agradable la experiencia dental.

FACTORES SOCIADOS A LA PERCEPCION PARENTAL Y ASISTENCIA AL DENTISTA

FERNANDO DE LA CRUZ MENDOZA
fernandodelacruz991@gmail.com
FATIMA DEL CARMEN AGUILAR DÍAZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ TRUJILLO, MARÍA DEL CARMEN VILLANUEVA VILCHIS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD LEÓN

INTRODUCCIÓN: La percepción de los padres sobre la salud bucal de sus hijos y la asistencia al odontólogo pueden verse condicionadas por diferentes eventos que provoquen dolor.

OBJETIVOS: Identificar la asociación de percepción parental sobre salud bucal, asistencia al odontólogo y dolor dental en los últimos 12 meses en niños de Guanajuato.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio transversal realizado en una población de 1-16 años perteneciente al Programa Sonrisas a niños de Guanajuato de la ENES, León UNAM, en el periodo 2018-2022. A través de un cuestionario estructurado se recolectaron datos sociodemográficos (edad, sexo, escolaridad madre) y sobre la percepción parental de la salud bucal, asistencia al odontólogo, tipo de atención (privada o pública), motivo de consulta y presencia de dolor dental en los últimos 12 meses.

RESULTADOS: Se incluyeron 651 pacientes, 51.5% femenino, edad promedio 6.9 (+3,1) años. 46% consideran regular o mala la salud bucal de sus hijos; 46.4% reportan dolor pocas veces a frecuentemente en los últimos 12 meses; 29.8% refiere haber asistido al odontólogo en los últimos 12 meses. 47.4% reporta como motivo de consulta la presencia de dolor y 31.4% (n=61) revisión y/o control. El 51.5% asistieron a un odontólogo del sector público. La percepción parental de la salud bucal no estuvo asociada a la asistencia al odontólogo, mientras que la presencia de dolor si está asociada ($p<0.001$).

CONCLUSIONES: Un alto porcentaje perciben como regular/mala la salud bucal de sus hijos, casi la mitad reporta haber padecido dolor, el cual es principal motivo de asistencia al odontólogo.

57

TIPOS DE PENSAMIENTO EMPLEADOS POR LOS ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA PARA OBTENER DIAGNÓSTICOS ACERTADOS

WILLEBALDO MORENO MÉNDEZ
wmorenoster@gmail.com
CARMEN LILIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
UNAM
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN: La tarea esencial de los odontólogos es la de diagnosticar y tratar, demandándoles conocer y aplicar correctamente el Método Clínico. Ante ello, es necesario que durante el proceso de formación de los estudiantes se fortalezcan competencias que promuevan el ejercicio de procesos cognitivos complejos que posibiliten la obtención de diagnósticos acertados.

OBJETIVOS: Identificar el tipo de pensamiento, y su dificultad, que emplean los estudiantes de odontología para obtener diagnósticos acertados.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio de tipo prolectivo, transversal y descriptivo. Se analizaron 15 variables que dan salida a los tipos de pensamiento, desde dos categorías: empleo del pensamiento y dificultad para su empleo. La muestra fue de tipo aleatoria simple por conveniencia de 200 estudiantes de odontología. Los resultados fueron evaluados y calificados con base a la siguiente escala: de 0% a 49%, nivel bajo o deficiente; de 50% a 79%, nivel medio o regular; de 80% a 100%, nivel alto o bueno.

RESULTADOS: a) Nivel de aplicación de los tipos de pensamiento. - Nivel alto: observación, comparación, comunicación, razonamiento clínico. - Nivel medio: identificación de la problemática, pensamiento lógico, procesamiento de la información, análisis y síntesis de la información, pensamiento hipotético-deductivo, integración del conocimiento, comprobación de diagnóstico presuntivo, pensamiento crítico, resolución de problemas, evaluación de tratamientos. - Nivel deficiente: no presentan ningún dato. b) Dificultad para ejecutar los diferentes tipos de pensamiento. - Nivel difícil: no se ubica ningún tipo de pensamiento. - Nivel medio difícil: identificación de la problemática, pensamiento hipotético-deductivo, pensamiento crítico, razonamiento clínico, evaluación de tratamientos. - Nivel poco difícil: los tipos de pensamiento restantes se ubican en este nivel.

CONCLUSIONES: Es evidente que los estudiantes tienen un nivel medio en el ejercicio de los tipos de pensamiento del Método Clínico para llegar a diagnósticos acertados. Lo que evidencia que es necesario fortalecer las competencias pertinentes.

58

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO IPQ-RD EN CUIDADORES DE NIÑOS ESCOLARES

ESBEYDE LIZBETH LUNA SANTIAGO
esbe_ydelun@hotmail.com
MARÍA DEL CARMEN VILLANUEVA VILCHIS, FÁTIMA DEL CARMEN AGUILAR DÍAZ, CARLO MEDINA SOLÍS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD LEÓN

INTRODUCCIÓN: La salud bucal depende de múltiples factores que incluyen los biológicos, familiares y sociales. El instrumento Illness Perception Questionnaire Revised for Dental (IPQRD) ayuda a identificar la percepción sobre los padres o cuidadores sobre la caries dental.

OBJETIVOS: Determinar la confiabilidad y validez de consenso del cuestionario IPQR-D sobre la percepción de caries dental en cuidadores de escolares.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio transversal de validación. El cuestionario IPQRD fue sometido a evaluación por parte de jueces calificados para determinar su validez de consenso a través del método de Lawshe. Una vez validado, el instrumento fue aplicado a cuidadoras de niños asistentes a la escuela primaria Leona Vicario en León Guanajuato. Se incluyeron a todas aquellas que aceptaran participar y que supieran leer y escribir. Una examinadora previamente estandarizada, aplicó los cuestionarios.

RESULTADOS: Participaron 124 padres o cuidadores, 115(92.7%) del sexo femenino y 9(7.3%) del sexo masculino, la edad promedio fue de 35.02 ±9.02 años. El valor de CVR' correspondiente a la validación fue de .85, es decir aceptable, se sugirieron modificaciones para los ítems: 19 y 27 En el análisis de confiabilidad de los 31 ítems nos muestra un Alpha de Cronbach de 0.87, lo que también se considera aceptable.

CONCLUSIONES: El instrumento IPQRD muestra adecuados valores de confiabilidad lo que permite que pueda ser aplicado en cuidadores de niños escolares tomando en cuenta la adaptación de los ítems ya mencionados.

59

RIESGO A CARIES EN INFANTES DE PREESCOLAR UTILIZANDO EL SISTEMA CAMBRA E ICDAS II

TERESA VILLANUEVA GUTIÉRREZ
tvillanueva@correo.xoc.uam.mx
MARTÍNEZ CASTAÑEDA YESENIA, COMPEÁN DARDÓN MARÍA SANDRA, MARTÍNEZ RUIZ FRANCISCO JAVIER, GARCÍA PÉREZ ÁLVARO.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA XOCHIMILCO
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD

INTRODUCCIÓN: Caries dental es un problema de salud pública, esta enfermedad afecta a todos los grupos de edad, apareciendo en la primera infancia y aumentando a lo largo de la vida. CAMBRA e ICDAS son sistemas que evalúan el riesgo a caries y la lesión en etapas tempranas.

OBJETIVOS: Evaluar el riesgo a caries en infantes preescolares de una escuela pública en el Estado de México aplicando el sistema CAMBRA e ICDAS.

MATERIAL / MÉTODOS: Se realizó un estudio piloto durante 2021, en infantes preescolares en una escuela del Estado de México. La caries fue evaluada con el sistema ICDAS II (International Caries Detection and Assessment System) se aplicó la encuesta CAMBRA (Caries Management by Risk Assessment) evaluando el riesgo a caries mediante los indicadores de enfermedad, factores de riesgo y factores protectores, la higiene bucal mediante el IHO-S. La evaluación bucal fue realizada por un odontólogo previamente estandarizados con una kappa ≥0.85 para caries.

RESULTADOS: 22 infantes (63.6% niños, 36.4% niñas)promedio de edad 4.32 (±0.839). 61.5% presentó mala higiene y 38.5% buena. Indicadores de enfermedad:36.4% presentaron tres o más lesiones cariosas (p=0.0001); 45.5% lesiones con cavidades visibles (p=0.0001); Factores de riesgo: 86.4% presentaba biopelícula visible, 59.1% fosas y fosetas profundas y 22.7% consumía bebidas azucaradas frecuentemente (p=0.034). Factores protectores: 9.1% acudieron al dentista para aplicaciones de flúor y 77.3% se cepillaba una vez al día; 40.9% presentaron riesgo bajo, 22.7% moderado y 36.4% alto.

CONCLUSIONES: La aplicación de sistemas que evalúen el riesgo a caries y la identificación de lesiones en etapas tempranas, permitirá aplicar medidas preventivas que reviertan-detengan la enfermedad.

61

EXPERIENCIA A CARIES Y DIENTES SANOS EN PACIENTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, TLAXCALA Y LA COLONIA PENSIL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; DENTRO DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL DE BRIGADAS DE SALUD BUCODENTAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNAM.

CARMEN SARAI OLIVARES PINEDA
odonto.unam.sarai@gmail.com
JUAN CARLOS RODRIGUEZ AVILES, ERIKA HEREDIA PONCE
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ODONTOLOGIA

INTRODUCCIÓN: En México, la promoción de la salud bucodental es insuficiente, reflejándose en la poca cultura de prevención y elevados índices de caries en la población, por tal motivo la Facultad de Odontología, se suma al trabajo en conjunto con el sector público.

OBJETIVOS: Describir el estado de salud bucodental de los pacientes que fueron atendidos, dentro del Programa de Servicio Social de Brigadas.

MATERIAL / MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal retrospectivo. Se registraron las historias clínicas realizadas a los pacientes que asistieron a la Brigada, en la Colonia Pensil en la CDMX (CP) y en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala (SCT), se obtuvo acceso al índice de CPOD y ceod para calcular la prevalencia de caries. Se realizó un análisis descriptivo para cada una de las variables involucradas, con la finalidad de comparar el estado de salud oral por localidad y sexo utilizando la prueba t-student.

RESULTADOS: La población estuvo constituida por un total de 628 pacientes, 47.45% de CP y 51% de SCT. El 62.7% del total de la población fueron mujeres. Las cifras de caries en ambas localidades están por arriba del 95%: CP 95.6% y SCT 96.7% ($p>0.05$), por sexo: 36.9% en hombres y 63.1% en mujeres ($p>0.05$).

CONCLUSIONES: Las enfermedades bucales son un problema, es por eso que la Facultad ha implementado estrategias para la promoción, prevención e intervención.

62

GUÍA DE PREVENCION EN CARIES DENTAL A PARTIR DE LA LSM

ITZEL GUTIÉRREZ WILLIAMS
itzel.williams17@gmail.com
MARÍA CONCEPCIÓN RAMÍREZ SOBERÓN, MIRIAM ORTEGA MALDONADO
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN: Según la OMS en el mundo existen 1,500 millones de personas con algún grado de pérdida de audición. En México hay 2.3 millones de las cuales el 34.4% tienen entre 30 y 59 años, y 47.4% mayores de 60 años.

OBJETIVOS: Realizar una guía en lsm para incluir a las personas con discapacidad auditiva en prevención por medio de la revisión de literatura.

MATERIAL / MÉTODOS: Se exploraron fuentes de información en las bases de datos PubMed, Revistas médicas digitales y SciELO desde 2017 hasta 2022. Se utilizaron los términos en español: “Discapacidad auditiva”, “Guía de prevención”, “tic´s en odontología”, “manejo del paciente sordo” y “caries dental”. El rastro ubicó 32 fuentes de información: nueve páginas institucionales, dos libros, cuatro revistas, 10 páginas web, dos apps y cinco artículos científicos.

RESULTADOS: Se elaboró una guía para facilitar la comunicación con las personas sordas respecto a la prevención de caries dental.

CONCLUSIONES: Lograr una comunicación con las personas sordas es fundamental para respetar sus derechos de acceso a la información y promover la inclusión en la salud.

63

ESTIMACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LA ESCALA DE SOPORTE SOCIAL PARA ADOLESCENTES.

MONTSERRAT GONZÁLEZ RIVAS
montsegr97@gmail.com
GONZÁLEZ RIVAS M, GALICIA DIEZ BARROSO D, BORGES YÁÑEZ S.A.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN: La estimación de la confiabilidad de un instrumento es necesaria, así se asegura que el constructor de interés será medido de manera fidedigna. La Escala de Soporte Social para Adolescentes contiene 22 ítems, obteniendo como resultado un puntaje de 22 a 110. Indicando que, a mayor puntaje, mayor soporte social.

OBJETIVOS: Estimar la confiabilidad de la ESSA en un grupo de estudiantes de 18 y 19 años de la Facultad de Odontología UNAM.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio transversal, muestra no probabilística calculada con los siguientes supuestos: Ítems K= 22 Individuos por ítem = 5 Muestra= 110 estudiantes Porcentaje de pérdida = 10% Total= 121 estudiantes. Aplicado de forma presencial, habilitado en Google Forms, en alumnos inscritos en la Facultad de Odontología, se incluyó un cuestionario con variables sociodemográficas, índice AMAI, escolaridad, ocupación de los padres. La confiabilidad se estimó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, mientras que la repetibilidad con el coeficiente de correlación intraclase, mediante la prueba re-reprueba.

RESULTADOS: La muestra total estuvo constituida por 121 estudiantes, 27 (22.3%) corresponden al sexo masculino y 94 (77.7%) al femenino. La media de edad fue 18.28 ± 0.45 años. Se calculó el coeficiente de Alpha de Cronbach para las 22 preguntas de la ESSA observando un valor de 0.89. Se aplicó la ESSA 24 días después en una submuestra de 33 estudiantes, obteniendo una repetibilidad de CCI= 0.83 p=0.001.

CONCLUSIONES: La ESSA posee altos valores de confiabilidad y repetibilidad.

64

PENSAMIENTO CRÍTICO COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL AUTOAPRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA DURANTE SU FORMACIÓN PROFESIONAL

CARMEN LILIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
carmenlilis@gmail.com
WILLEBALDO MORENO MÉNDEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN: En el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación las actitudes y conductas que muestran los estudiantes hacia dicho proceso son determinantes para el logro de los objetivos de aprendizaje. El desarrollo del pensamiento crítico coadyuva de manera significativa a que el estudiante sea capaz de pensar por sí mismo, argumentar y tomar decisiones.

OBJETIVOS: Identificar en estudiantes de nuevo ingreso, las estrategias que emplean para desarrollar el pensamiento crítico.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio descriptivo, observacional, prolectivo y transversal. Se aplicó un cuestionario tipo Lickert a 250 estudiantes de primer ingreso, con cuatro categorías de análisis: adquisición de información, codificación de información, recuperación de la información y apoyo al procesamiento de la información y 17 variables.

RESULTADOS: Adquisición de la información: reconocimiento del tema 19%, anotación de la información 49%, mapas conceptuales 15%, tema estudiado 45%, subrayado del contenido 38%. Codificación de la información: pensamiento crítico 33%, 65% profundización del tema, 20% establecen analogías, 18% logran crear sus propias conclusiones, 9% amplían la información recibida. Recuperación de la información: 30% organiza y realiza diferenciación de ideas, 28% destaca los puntos importantes, 13% capaces de encontrar una semejanza en un conjunto de hechos, 20% relacionar contenidos de distintas materias, 24% buscan alternativas para resolver problemas. Apoyo al procesamiento de la información: automotivación para el estudio 46%, participan en grupos de estudio para intercambiar puntos de vista sobre un tema 25%.

CONCLUSIONES: En base a los resultados antes mencionados del estudio en cuestión, podemos determinar que un muy bajo porcentaje de los estudiantes, son capaces de generar un pensamiento crítico, lo cual se verá reflejado en la forma en que generaran y adquirirán nuevos conocimientos.

65

SALUD BUCAL EN NIÑOS INDIGENAS DE UNA ESCUELA PRIMARIA PÚBLICA BILINGÜE

DENISSE DURAN MERINO
duranmde7@gmail.com
CARLOS GONZÁLEZ CASAMADA, LEONOR SÁNCHEZ PÉREZ, ENRIQUE CASTAÑEDA, ROSINA VILLANUEVA ARRIAGA, NELLY MOLINA FRECHERO.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO ATENCIÓN A LA SALUD, DIVISIÓN CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD. UAM XOCHIMILCO

INTRODUCCIÓN: La higiene oral cumple un rol importante para la prevención en la salud bucal sin embargo la caries dental sigue siendo un problema de salud pública en México, donde se han realizado pocos estudios en población indígena.

OBJETIVOS: Analizar la higiene bucal y la caries dental en niños indígenas de una escuela primaria pública bilingüe.

MATERIAL / MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal, en escolares de 10 y 11 años de edad con consentimiento informado. La higiene bucal fue valorada con poca o mucha de acuerdo al índice de O'Leary, y con el índice Silness y Löe considerando los niveles de placa dental en rangos de 0, 1/3 poca, 2/3 mucha. La caries fue evaluada mediante el índice para dentición temporal cpod utilizando criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La información se registró en Excel y se analizaron con estadística descriptiva en SPSS 23.

RESULTADOS: La muestra estuvo constituida por 101 niños de ambos sexos. En los niños que presentaron caries dental el 64.7% presentó mala higiene bucal y el 66.2% mucha placa dentobacteriana, mientras que los niños libres de caries dental el 57.6% presentaron buena higiene bucal y con poca placa dentobacteriana 87.9% niños.

CONCLUSIONES: Se recomienda implementar medidas preventivas de salud bucal con énfasis en higiene bucal para la prevención de la caries dental en escolares de poblaciones indígenas.

66

ESTADO DE SALUD BUCAL DE NIÑOS CON TEA EN EDAD ESCOLAR: ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES

SUSANA BEATRIZ ESPARZA LOREDO
susan_eslo@hotmail.com
GUADALUPE S. GARCÍA DE LA TORRE, MA. DEL CARMEN VILLANUEVA VILCHIS, MA. SARAY ARANDA ROMO, HURI ANAID MORALES SAAVEDRA, FÁTIMA DEL CARMEN AGUILAR DÍAZ.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES-UNIDAD LEÓN

INTRODUCCIÓN: La desintegración sensorial en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), juega un papel determinante en su estado de salud. La predilección alimentaria y su alta sensibilidad en cavidad bucal predisponen a condiciones bucales como caries, asociada a deficiente higiene bucal y alto consumo de azúcares.

OBJETIVOS: Comparar el estado de salud bucal (experiencia de caries e higiene oral) en niños con/sin condición de TEA de San Luis Potosí.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio observacional realizado durante agosto-diciembre 2022- en San Luis Potosí. Participaron 60 niños (20 con TEA y 40 neurotípicos -emparejados por sexo y edad) de 5 y 12 años. Se recabaron datos sociodemográficos (edad, sexo) y datos clínicos bucales sobre experiencia de caries mediante sistema ICDAS e higiene bucal con el IHO-s.

RESULTADOS: En total participaron 60 niños, edad promedio edad de 7.5 (±2.1). Proporción 9:1 (H:M). Prevalencia de caries: 95% en niños neurotípicos y 60% niños con TEA ($p < 0.001$). Presencia de lesiones de caries iniciales (ICDAS 1-2), fue más frecuente en niños con TEA (6.7%) y caries moderada (ICDAS 3-4) en grupo control (3.9%). En cuanto al IHO-S, los valores clínicos para más del 50% de niños y en ambos grupos, se categorizó un DI-S deficiente (2.0, niños neurotípicos y 1.9 para niños con TEA).

CONCLUSIONES: La prevalencia de caries fue menor en niños con TEA. La higiene y salud bucodental muestra posible riesgo al presentarse considerable acumulación de biofilm en ambos grupos.

67

EL DESEMPEÑO DOCENTE ASOCIADO A LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA.

CARLOS ANDRES GONZALEZ MIRANDA
c.andresgonzalezm@gmail.com
CARMEN LILIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ , WILLEBALDO MORENO MÉNDEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FES ZARAGOZA

INTRODUCCIÓN: El desempeño docente es un factor clave en la calidad de la formación profesional, por medio de las acciones y los objetivos propios de la actividad pedagógica y didáctica del docente, durante la enseñanza y aprendizaje, esencial para el éxito académico de los egresados.

OBJETIVOS: Identificar los principales factores que intervienen en la formación profesional asociados al desempeño del docente.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio observacional, prolectivo, transversal y descriptivo. Se aplicó un cuestionario a una muestra de 176 egresados para evaluar 13 variables relacionadas al desempeño docente. Los resultados se organizaron por porcentajes a través de la siguiente escala para determinar la calidad de los factores: de 0 a 49%, nivel deficiente; de 50 a 79%, nivel regular y de 80 a 100%, nivel bueno.

RESULTADOS: Los factores de desempeño docente identificados que obtuvieron nivel regular son: Entrega de los programas de estudio, Dominio de la disciplina, Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos, Claridad expositiva, Uso de diversas estrategias de enseñanza, Motivación para la actualización de nuevos conocimientos, Promover la participación en clase, Empleo de la tecnología de la información, Evaluación objetiva de los exámenes, Resolución / aclaración de dudas, Cumplimiento del programa de estudios. Los factores que obtuvieron un nivel bueno son: Evaluación de las actividades clínicas y Promoción del trabajo colaborativo.

CONCLUSIONES: La calidad del desempeño docente se caracteriza en un nivel regular, lo cual indica que aún es necesario promover programas y estrategias para su capacitación y mejoramiento.

68

CALIDAD DE VIDA ASOCIADA A SALUD BUCAL Y DEPRESION EN ANCIANOS EN CDMX

GABRIELA ALEJANDRA VELASCO PÉREZ
g_a_b_y18497@hotmail.com
MA. ESTHER IRIGOYEN CAMACHO, CONSUELO VELÁZQUEZ ALVA, MARCO ANTONIO ZEPEDA ZEPEDA, NELLY MOLINA FRECHERO, LEONOR SÁNCHEZ PÉREZ
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD

INTRODUCCIÓN: La depresión afecta el estado de ánimo, cognición y comportamiento de una persona. Se ha identificado una relación entre el estado bucal y la salud mental del anciano. Existe poca información sobre la calidad de vida asociada a la salud bucal (CVASB) y la depresión.

OBJETIVOS: Identificar la asociación entre síntomas depresivos y CVASB en personas mayores de 60 años que viven en residencias geriátricas en la CDMX.

MATERIAL / MÉTODOS: Se seleccionaron dos residencias geriátricas ubicadas al sur de la CDMX. Los participantes debían ser capaces de contestar preguntas relacionadas con su boca y un cuestionario sobre síntomas depresivos (Yesavage). Se obtuvo del consentimiento informado de cada participante. El cuestionario General Oral Health Assessment Index (GOHAI) se aplicó para identificar CVASB. Se construyó un modelo de regresión logística múltiple para obtener los momios (RM) de presentar depresión moderada y severa asociados al puntaje GOHAI.

RESULTADOS: Se incluyó a 169 ancianos, con una edad promedio 82.72 años, de los cuales 60.05% fueron mujeres y 31.95% hombres. El porcentaje de ancianos identificados con depresión establecida fue de 15.98%, con depresión leve 23.67%, en la categoría normal 60.36%. El promedio de puntaje GOHAI fue 48.87 (SD 10.96). Los resultados del modelo logístico mostraron que existe una asociación entre el resultado de GOHAI y la sintomatología depresiva (RM =1.10 95% CI (1.06, 1.14, <0.001), este modelo fue ajustado por edad (p>0.05) y sexo (p>0.05).

CONCLUSIONES: El impacto negativo en la calidad de vida asociada a la salud bucal presentó mayor probabilidad de sufrir síntomas depresivos. Se requiere mejorar las condiciones salud de los ancianos.

69

ESTIMULACIÓN SIALOQUIMICA MEDIANTE FITOTERAPIA EN PACIENTES CON SÍNDROME DE DOWN

GLORIA PATRICIA PEREA GONZALEZ
gloria.perea@correo.buap.mx
MARIO EMANUEL BALDERAS-FLORES; HAZEL CORDERO-PEREA; ABIGAILT FLORES-LEDESMA; BLANCA CORTEZ-RODRIGUEZ; FRANCISCO LAZARO BALDERAS GOMEZ; RAFAEL URIEL PEREZ ZACARIAS (202051698)
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA Y MEDICINA PUEBLA Y TEHUACAN

INTRODUCCIÓN: Los factores de riesgo orales en niños con Síndrome de Down varían, lengua escrotal, fisurada, aumento del pH, secreción disminuida provocando susceptibilidad a caries y periodontopatías. Para disminuir la susceptibilidad, se produjeron perlas con Quercus Ilex y estimular el flujo salival en niños Down.

OBJETIVOS: Demostrar las propiedades de las perlas impregnadas con Quercus Ilex como efecto estimulante para el Flujo Salival en los pacientes con síndrome de Down.

MATERIAL / MÉTODOS: Historias clínicas, consentimiento informado, perlas con Extracto de Quercus Ilex al 40%, papelería, Software para obtener resultados. Estudio transversal, descriptivo, comparativo, observacional. Recolección de datos y sialiquimico, 20 muestras asignándoles folio: nombre, edad, género, (8/12 años), marzo-julio 2022, se presentaron niños de la fundación Down (Puebla), sin enjuagar la boca, en ayunas, horario 08:00 a 10:00AM. Se colectó saliva no estimulada por un minuto pre y postratamiento, técnica de escurrimiento.

RESULTADOS: Se expresan en mL/min de saliva. Tratamiento a seguir durante 15 días, colocar en el carillo perlas impregnada con Quercus Ilex y jugar con la lengua la perla (3/v al día durante 2 minutos) Los resultados arrojan que un niño presentó xerostomía antes del tratamiento y postratamiento se incluye como Flujo muy bajo (0.08/0.85) De las niñas, una presento hipersalivación, postratamiento pasó a flujo muy bajo (2.23/0.28) sin encontrar posible causa. En general se logró demostrar que las perlas impregnadas con Quercus Ilex tienen efecto estimulante en el FS de los pacientes con SD.

CONCLUSIONES: Establecer adecuada intervención educativa en técnica de cepillado y factores dietéticos al paciente con SD, requieren apoyo del familiar y usar Quercus Ilex como estimulante del FS.

70

CAMBIOS COMPARATIVOS BIDIMENSIONALES DE VÍAS AÉREAS SUPERIORES POST DISYUNCIÓN MAXILAR RÁPIDA, EN LA PRÁCTICA ORTODÓNCICA

CLAUDIA ELIZABETH MORA CANELA
lizmc_2806@hotmail.com
GERARDO MARTINEZ, ALMA DELIA LUNA MATA
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ

INTRODUCCIÓN: En la actualidad se ha retomado la importancia del análisis de las vías aéreas superiores (VAS),en relación con el desarrollo cráneofacial. Los trastornos respiratorios causan alteraciones del sueño(AOS),repercutiendo en la calidad de vida y en el crecimiento del individuo.

OBJETIVOS: Comparar los cambios bidimensionales de VAS, posterior a la disyunción máxilar rápida en pacientes con trastornos respiratorios en HIMFG.

MATERIAL / MÉTODOS: 13 pacientes pediátricos a conveniencia remitidos por servicio de Otorrinolaringología, P.O de adenoamigdalectomía. de 8-12 años. Consentimiento informado, firmado por padre o tutor. Se analizaron y trazaron 26 radiografías laterales de cráneo estandarizadas (con labios en reposo y posición natural de la cabeza). Se obtuvieron dimensiones del espacio faríngeo AD1-AD2 con método de Linder-Aronson, nasofaringe, Orofaringe e Hipofaringe,ancho maxilar (JR-JL) en radiografías postero anteriores. Se realizo la prueba de Tstudent,ANOVA.

RESULTADOS: 76.9% fueron niños (n= 10), la media del ángulo ANB fue de 2.9° ± 2.8, la media de edad fue de 10.53± 1.3. La media de AD1 antes de la DMR fue de 14.1 ±2.6, la media de AD1 posterior a la ERM fue de 14.5±2.7, La dimensión AD2 antes y después de la ERM fue de 12.8±3.4 y de 14.6±3.7 Al comparar la dimensión AD2 post expansión entre el sexo se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($p \leq 0.05$).

CONCLUSIONES: Las dimensiones de AD2 fue diferente entre género antes y después de la DMR. Aunque se pudo observar los cambios bidimensionales recomendable evaluar VAS en tercera dimensión.

71

EVALUACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SALUD BUCAL - COLOMBIA 2006-2017

MAURICIO ALBERTO CORTES CELY
MA.CORTES140@UNIANDES.EDU.CO
LUIS JORGE HERNÁNDEZ, FARITH GONZALEZ, COSTANZA LOZANO
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ
FACULTAD DE MEDICINA, GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN Y PROFESIONALISMO MÉDICO

INTRODUCCIÓN: Colombia a través del ENSAB-IV (Estudio Nacional de Salud Bucal), evidencia que las condiciones de salud bucal incluyen altas tasas de prevalencia en enfermedades bucales prevenibles, inequidades en la oferta y prestación de los servicios, indicadores con valores similares a los encontrados en el ENSAB-III.

OBJETIVOS: Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas por el Plan Nacional de Salud Bucal.

MATERIAL / MÉTODOS: El estudio tiene un diseño descriptivo evaluativo a partir de la información recolectada sobre salud bucal desde el 2006 al 2017. Los lineamientos para seleccionar la información relevante se toman desde la política pública de PNSB. Las etapas para la realización de proyecto incluyen: la identificación de fuentes de información, recolección de información, análisis e interpretación.

RESULTADOS: Las metas no fueron cumplidas, al pasar los años los casos aumentan en todos los departamentos siendo el 2017 el año con más casos para Enfermedad periodontal y caries y 2014 para Enfermedad de tejidos blandos. Bolívar y Atlántico los departamentos con mayor índice de casos en cada evento mientras que San Andrés y Providencia maneja los números más bajos. Con relación a la tasa de atención por cada 1000 habitantes los departamentos Bolívar, Cesar y Guajira encabezan la lista de atenciones, mientras que San Andrés y Sucre presentaron las tasas más bajas.

CONCLUSIONES: La Salud Bucal presenta deficiencias y altas prevalencia de enfermedades prevenibles, sumado a bajos niveles de atención. Los adultos mayores son los más perjudicados.

72

SALUD ORAL EN ADULTOS MAYORES DE ZONAS RURALES

YOLANDA LARIOS FELIX
yolandalarios013@live.com
ERIKA HEREDIA PONCE
SECRETARIA DE SALUD GUERRERO
ESTOMATOLOGIA

INTRODUCCIÓN: La salud oral debe definirse como el bienestar físico, psicológico y social en relación con el estado de la dentición, tejidos duros y blandos bucales. El deterioro gradual de la salud oral en la población adulta mayor influye de manera importante sobre la calidad de vida de las personas. Los adultos mayores de las zonas rurales se encuentran en mayor vulnerabilidad debido a la falta de educación y promoción de la salud, difícil acceso a los servicios de salud y escasos recursos económicos.

OBJETIVOS: Explorar la percepción del estado de salud oral de los adultos mayores de zonas rurales, específicamente la localidad de Hueycantenango, Guerrero, México.

MATERIAL / MÉTODOS: Se realizaron entrevistas a profundidad en adultos mayores de 60 años y más de la localidad de Hueycantenango, Guerrero, México que acuden a solicitar el servicio dental del centro de salud Hueycantenango.

RESULTADOS: Se entrevistó a 3 pacientes adultos mayores de la localidad de Hueycantenago, Guerrero. Se confirma la falta de información sobre el cuidado y bienestar de la salud oral. Los entrevistados se refieren a la pérdida dental como un estado normal del proceso de envejecimiento, el uso reciente y poco frecuente de cepillo y pasta dental, reciente acceso a los servicios de salud oral, mencionan que de haber tenido conocimiento sobre los cuidados de salud oral tiempo atrás, huebieran podido cuidar sus dientes y con ello hubieran evitado dolor, gastos innesecarios, sentimientos de tristeza por la incapacidad para comer y disfrutar los alimentos.

CONCLUSIONES: La prevención y promoción de la salud oral entre los adultos mayores es una actividad que debe estar presente en los servicios de salud.

73

FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD BUCAL EN UNIVERSITARIOS DE PACHUCA DURANTE 2022: ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

KAREN KRISTEL SANTOS GARCÍA
cd.karen.santos@gmail.com
CARLO EDUARDO MEDINA SOLÍS, ARTURO SALAZAR CAMPOS, NORA ELENA SOSA BERMÚDEZ, PABLO ÓSCAR ROMERO ISLAS, AMÉRICA PATRICIA PONTIGO LOYOLA.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD

INTRODUCCIÓN: Estudios de autopercepción de salud han tomado importancia ya que son una medida confiable de necesidades en salud bucal aunado con estudios de género que permiten evaluar impacto de determinantes sociales y aproximándose a la realidad de la población universitaria desde una perspectiva de género.

OBJETIVOS: Analizar, desde una perspectiva de género, los factores asociados a la autopercepción de la salud bucodental en una población universitaria.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio transversal realizado en una población de una universidad pública de Hidalgo, México. La salud oral autoevaluada se evaluó en base a una sola pregunta "¿Cómo consideras tu salud bucal en general?" y 5 indicadores que permitieron el análisis con perspectiva de género. Se utilizaron como covariables la edad, sexo biológico y Estado civil.

RESULTADOS: Muestra total de 997 sujetos, la mayoría fueron mujeres (53.3%). Los sujetos reportaron estar solteros, sin embargo, en menor proporción también reportaron estar casados. Los hombres reportaron peor salud bucal general que las mujeres ($p=0.003$), sin embargo se observó que fueron las mujeres quienes reportaron tener peor alineados sus dientes ($p<0.01$) Los sujetos que percibieron una buena salud presentaron un promedio de edad menor que los que señalaron tener una mala salud ($p=0.0001$).Se observó que los individuos que no tienen pareja consideran tener una mejor salud bucal en comparación con quienes si la tienen ($p<0.01$).

CONCLUSIONES: Mujeres señalaron tener mejor salud bucal que los hombres, pero consideran peor alineados dientes. A mayor promedio de edad peor perciben salud bucal. La convivencia con pareja determina la percepción.

74

COMPARACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE CUIDADORES PRINCIPALES DE NIÑOS CON Y SIN LABIO HENDIDO QUE ASISTEN A UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA UNIVERSITARIA

KAREN ESPERANZA ALMANZA ARANDA
karen.esp2006@gmail.com
JAVIER DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN VILLANUEVA VILCHIS, LUIS ALBERTO GAITÁN CEPEDA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD LEÓN

INTRODUCCIÓN: El labio y paladar hendido (LPH) es una de las anomalías congénitas más comunes que afectan las estructuras orofaciales. Los pacientes que la presentan necesitan recibir tratamientos integrales para corregirla, por lo que sus cuidadores principales deben brindarles cuidado y atención constantemente.

OBJETIVOS: Comparar calidad de vida de principales cuidadores de niños con LPH con aquellos sin esta condición que asistieron a una clínica de Odontológica.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio transversal pareado en la Clínica Odontológica de la ENES UNAM, de mayo a diciembre de 2021. El estudio incluyó a cuidadores principales de niños con LPH (n=70) que asistieron al “TiENES que sonreír, UNAMos esfuerzos”, así como los principales cuidadores de niños sin LPH (n=70) que acudieron a la Clínica de Odontopediatría. La selección de los participantes se realizó mediante muestreo por conveniencia. El cuidador principal llenó un cuestionario con el instrumento WHOQOL Bref.

RESULTADOS: La Calidad de Vida reportada por los cuidadores, se identificó que los encargados de pacientes con hendidura relataron mala calidad de vida (64.8%), en comparación con los cuidadores del grupo control que reportaron mejor calidad de vida (65.2%). Los cuidadores que tienen niños con LPH tienen 3,2 veces más probabilidades de tener una mala calidad de vida, mientras que aquellos cuidadores con niveles clínicos de estrés tienen 1,02 veces más probabilidades de tener una mala calidad de vida. La calidad de vida se vio más afectada en aquellos con estudios hasta el nivel secundaria y en los desempleados.

CONCLUSIONES: La calidad de vida se vio más afectada en el grupo de cuidadores de niños con LPH. Factores sociodemográficos pueden influir en esa calidad de vida.

75

PROTESIS TOTALES EN UN PACIENTE GERIATRICO

ANDREA PAOLA GONZÁLEZ ARROYO
ANDREAPAOLAGONZALEZARROYO@gmail.com
ANA GABRIELA GOMEZ VALENCIANO, MONTOYA GARCÍA ATZIRY VIANER, OLIVARES CAMARENA MONICA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

INTRODUCCIÓN: Uno de los principales retos de la odontología es preservar en boca el mayor número de dientes el mayor tiempo posible. Sin embargo, el edentulismo sigue teniendo una alta prevalencia alrededor del mundo. El tratamiento consiste en un dispositivo-físico mecánico que recupere el equilibrio perdido.

OBJETIVOS: Proporcionar un aparto proteico removible que reemplace artificialmente la totalidad de los dientes en un paciente edéntulo de ambos arcos dentales.

MATERIAL / MÉTODOS: Procedimiento: toma de modelos preliminares, toma de impresiones funcionales, encajonado, realización de modelos maestro, montaje en articulador, transferencia de registros, montaje de dientes.

RESULTADOS: Se obtuvo un resultado favorable para el paciente en cuestión gracias a la recuperación de las funciones de los tejidos y órganos dentales, así como la expresión facial y la integración social.

CONCLUSIONES: La correcta comunicación entre el odontólogo-paciente es fundamental para la comprensión de las necesidades y expectativas de este último, favoreciendo el plan de tratamiento.

76

ENFERMEDAD PERIODONTAL Y SU PAPEL EN LA SALUD GENERAL

CASTAÑEDA CASTANEIRA ENRIQUE
rcastane@correo.xoc.uam.mx
NELLY MOLINA FRECHERO, ENRIQUE GAONA, GUADALUPE ROBLES PINTO, DENISSE DURÁN MERINO.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA- XOCHIMILCO
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD

INTRODUCCIÓN: La periodontitis incluye enfermedades crónico-inflamatorias que alteran al periodonto, encías, ligamentos y el hueso. De origen multifactorial predominando la infección, mala higiene y el estrés. Origina complicaciones como caries, procesos endoperiodontales, abscesos periodontales, diabetes, infecciones respiratorias, ateroesclerosis, cardiopatías y complicaciones del embarazo.

OBJETIVOS: Detectar las posibles complicaciones locales y sistémicas de la enfermedad periodontal.

MATERIAL / MÉTODOS: Estudio descriptivo, observacional y transversal en pacientes adultos de ambos géneros ingresados en medicina interna del Hospital General de Salubridad. Se practicó a los enfermos una evaluación bucal por un odontólogo calificado, quien evaluó la presencia de enfermedad periodontal utilizando los criterios de la ADA, clasificándolas en: Tipo I, II, III y IV. Diagnosticados con enfermedad periodontal valorados conjuntamente con el Médico Internista para identificar si sus problemas médicos están relacionados.

RESULTADOS: Se estudio un total de 300 pacientes de 40 a 65 años de edad, 60% femeninos y 40% masculinos. Con periodonto sano fueron 60% y con enfermedad periodontal 40%. La enfermedad periodontal se distribuyó en: Tipo I = 28%, Tipo II = 38%, periodontitis Tipo III = 26% y Tipo IV = 8%. 40 tenían gingivitis y 80 a periodontitis. Los padecimientos locales o sistémicos que pudieran relacionarse con la enfermedad fueron: Osteomielitis de mandíbula3%, celulitis facial 10%, abscesos dentales 15%, perdidas dentarias 20%, movilidad dental 35%, gingivitis ulcero necrosante aguda 2%, Infarto al miocardio 6%, miocarditis 4%, cetoácidos o coma diabético 8%, disfunción eréctil 10%.

CONCLUSIONES: Debido a los resultados encontrados es importante realizar actividades para promover la prevención y el manejo temprano de la enfermedad periodontal y evitar sus efectos locales y sistémicos.

77

PATOLOGÍA BUCAL EN PACIENTES QUE ACUDEN A UNA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA UAM.

CASTAÑEDA CASTANEIRA ENRIQUE
rcastane@correo.xoc.uam.mx
LORENA LÓPEZ GONZÁLEZ, DENISSE DURAN MERINO, GUADALUPE ROBLES PINTO.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA- XOCHIMILCO
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD

INTRODUCCIÓN: El propósito del presente trabajo fue determinar la prevalencia de enfermedades bucales en jóvenes y adultos que asisten a la Clínica Estomatológica de San Lorenzo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

OBJETIVOS: Evaluar las enfermedades que presentan los pacientes que acuden a una clínica estomatológica de la UAM.

MATERIAL / MÉTODOS: Se revisaron los expedientes de pacientes que acuden a la clínica San Lorenzo de la UAM para recabar los datos de las enfermedades bucales que se diagnosticaron durante su asistencia. Los padecimientos se clasificaron en seis grupos: caries dental, enfermedad periodontal, enfermedades pulpares, enfermedades de tejidos blandos, maloclusión y lesiones traumáticas.

RESULTADOS: Fueron revisados 278 expedientes, de ambos sexos, de 20 a 60 años. La caries se presentó en 90.28%, enfermedad periodontal en 79.85%, problemas pulpares 73.38%, enfermedad de tejidos blandos 34.89%, maloclusión 32.01% y lesiones traumáticas 25.18%%. La caries de tercer grado fue del 33.3%, la gingivitis predominó en 50%, la pulpitis se encontró en el 46.04%, la maloclusión más frecuente fue la de Clase I (neutroclusión) en 40.45% presentaron trauma periodontal y mala oclusión en 47.05%.

CONCLUSIONES: Fueron revisados 278 expedientes, de ambos sexos, de 20 a 60 años. La caries se presentó en 90.28%, enfermedad periodontal en 79.85%, problemas pulpares 73.38%, enfermedad de tejidos blandos 34.89%, maloclusión 32.01% y lesiones traumáticas 25.18%%. La caries de tercer grado fue del 33.3%, la gingivitis predominó en 50%, la pulpitis se encontró en el 46.04%, la maloclusión más frecuente fue la de Clase I (neutroclusión) en 40.45% presentaron trauma periodontal y mala oclusión en 47.05%.

78

DIABETES MELLITUS TIPO I y ENFERMEDAD PERIODONTAL EN ADOLESCENTES

CASTAÑEDA CASTANEIRA ENRIQUE
rcastane@correo.xoc.uam.mx
NELLY MOLINA FRECHERO, ENRIQUE GAONA. GUADALUPE ROBLES PINTO.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA- XOCHIMILCO
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD

INTRODUCCIÓN: La diabetes mellitus es una enfermedad sistémica que alterar la respuesta inflamatoria a nivel bucal en presencia de irritantes locales, provocando mayor prevalencia y severidad de enfermedad periodontales en pacientes diabéticos.

OBJETIVOS: Evaluar la frecuencia y características de la enfermedad periodontal en adolescentes con diabetes mellitus tipo 1.

MATERIAL / MÉTODOS: Se realizó un estudio en pacientes adolescentes de ambos géneros con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 que asisten al Hospital Infantil de Iztapalapa, con evolución de la enfermedad no menor a tres años. Un odontólogo evaluó la enfermedad periodontal utilizando los criterios de la ADA, clasificándolas en: Tipo I, II, III y IV. Los resultados se correlacionaron con el control de la diabetes y con los valores de hemoglobina glucosilada (HbA1c) se clasificaron en diabéticos controlados, moderadamente controlados y no controlados.

RESULTADOS: Se evaluaron. 100 diabéticos de 13 a 17 años, 60% femeninos, 40% masculinos. 50% presentaron periodonto sano y 50% con enfermedad periodontal: 14 mostraron gingivitis y 36 periodontitis. La enfermedad periodontal se distribuyó en: Tipo I 14%, Tipo II 19%, Tipo III 13% y Tipo IV 4%. Los pacientes menos controlados presentaron mayor porcentaje de enfermedad periodontal y cursaron con mayor severidad. Relacionando los valores de hemoglobina glucosilada (HbA1) y la presencia de enfermedad periodontal, se observó que entre más deficiente es el control de la diabetes aumenta la enfermedad periodontal.

CONCLUSIONES: La enfermedad periodontal en diabéticos es elevada comparativamente con la encontrada en no diabéticos, existe una relación directa entre diabetes mal controlada y presencia o agravamiento de la enfermedad periodontal.

79

FRECUENCIAS DE HABITOS ORALES EN NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS

LETICIA OROZCO CUANALO
letyocu@yahoo.com
GUSTAVO DE JESÚS AGUILAR LARIOS, LUIS ALBERTO BECERRIL SALAZAR
FES ZARAGOZA
CIRUJANO DENTISTA

INTRODUCCIÓN: Los hábitos orales como la succión digital, la deglución atípica y la respiración bucal pueden modificar la posición de los dientes y relación y forma de las arcadas dentarias los hábitos de presión interfieren en el crecimiento normal.

OBJETIVOS: Determinar la frecuencia de hábitos orales en niños de 4 a 5 años.

MATERIAL / MÉTODOS: Tipo de estudio Observacional, descriptivo, transversal y prolectivo El universo de estudio es de 186 niños nivel preescolar de 4 a 5 años, del jardín de niños del municipio de Chimalhuacán, Edo de México. Se revisaron Succión digital, Succión labial, Onicofagia, Deglución atípica, Proyección lingual, Incompetencia labial, Respirador bucal, Morder objetos Tipo de oclusión mordida borde a borde, profunda, cruzada anterior, cruzada posterior, abierta posterior y anterior, overjet, overbite.

RESULTADOS: Se examinaron 186 sujetos del jardín de niños de Chimalhuacán, la muestra fue de 164 niños, 43.9% sexo femenino y 56. 1% masculino. Se observó con hábito bucal en el masculino 22.6% y femenino 12.2% ambos sexos fueron de 34.8% con hábito bucal y 65.2% no presento hábito bucal. A los cuatro años prevalencia del 18.9% y 15.9%; cinco años 34.8% con presencia y 65.2% sin hábito. Morder objetos 14.9%, respiración bucal 12.8% y succión digital con 11% y deglución atípica con un 1. 2%.

CONCLUSIONES: • La presencia de hábitos bucales fue del 34 8 22 6 del sexo masculinos y 12 2 del sexo femenino 18 9 en la edad de cuatro años y 15 9 en la edad de cinco años •El grupo de edad más afectado por el hábito bucal fue el de 4 años de edad •El hábito bucal con mayor frecuencia fue el de morder objetos seguido por respiración bucal y succión digital •Cabe destacar que hubo escolares que presentaron más de un hábito.